



The relationship of motor hyperactivity to some language disorders in a sample of children with lip dysplasia bunny

Operations

Eman Qadi Heba Abdel-Hamid

Master's Researcher

Prof. Ashraf Mohamed Abdel-Ghani Shreit

Professor of Special Education –
Faculty of Early Childhood Education,
Alexandria University

Prof. Walid Farouk Hassan Sayed

Associate Professor of Language and
Speech Disorders – Faculty of Special
Needs Sciences, Beni-Suef University

Abstract: The aim of the current research is to reveal the relationship between motor hyperactivity and some language disorders in a sample of cleft lip children . The descriptive (correlation , comparative) approach was relied upon , and the sample consisted of (25) male and female children from cleft lip children, ranging in age from Between 3 and 6 years, the following tools were used : the motor Hyperactivity Scale (prepared by Jamal Al- Khatib) and the language disorders scale(prepared by (Ahmed Abu Hasiba) and the results indicated that there is a correlation between motor hyperactivity and language disorders among a sample of cleft lip children.

Keywords: hyperactivity , language disorders , cleft lip .

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

إعداد

إيمان قاضي هيبة عبد الحميد

باحثة ماجستير

أ.م.د/ وليد فاروق حسن سيد

أستاذ مساعد اضطرابات اللغة والتخاطب

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة - جامعة بني

سوف

أ.د/ أشرف محمد عبد الغني شريت

أستاذ التربية الخاصة - كلية التربية للطفولة

المبكرة - جامعة الاسكندرية

المستخلص: هدف البحث الحالي هو كشف العلاقة الارتباطية بين فرط النشاط الحركي و بعض اضطرابات اللغة (الحذف و الابدال) لدى عينة من اطفال الشفة الأرنبية . و تم الاعتماد علي المنهج الوصفي (الارتباطي المقارن).و تكونت العينة من (٢٥) طفل و طفله من اطفال ذوى الشفة الأرنبية و تتراوح اعمارهم من (٦:٣)سنوات. و تم استخدام الادوات التالية : مقياس فرط النشاط الحركي(اعداد جمال الخطيب) و مقياس اضطرابات اللغة (اعداد احمد ابو حسيه) . و اشارت النتائج الي وجود علاقه ارتباطيه بين فرط النشاط الحركي و اضطرابات اللغة عند اطفال الشفة الأرنبية اي ان كلما زاد فرط النشاط الحركي لدي اطفال الشفة الأرنبية كلما زادت اضطرابات اللغة (الحذف و الابدال) لديهم.

الكلمات المفتاحية: : فرط النشاط الحركي - اضطرابات اللغة -الشفة الأرنبية.

المقدمة:

تعتبر حالات الشفة الأرنبية أو ما يسمى بحالات شق الشفة و الحنك من اكثر الحالات ظهورا بين الاطفال و هي من اكثر التشوهات الخلقية حدوثا و مع عدم وجود احصائيات دقيقة في الدول العربية فان نسبتها تماثل النسب العلمية حيث تصل الي حالة لكل ٨٠٠-٦٠٠ مولود لذلك يجب الاهتمام بمدي خطورة ظهور هذه الحالات و بالخصوص عند تأثيرها علي اضطرابات اللغة (عبدالله و اخرون، 2019) و هناك دراسات عديده تدل علي هدي اهمية الشفة الأرنبية و منها علي سبيل المثال (د ا رسة فولكير وآخرون (Volker, et al, 2014)ألمانيا . التي توضح مدي تاثير الشفة الأرنبية على الاطفال من حيث اللغة و الجوانب الاخرى و اسلوب تعامل الوالدين علي الاطفال .

تعد الشفة الارنبية من اشهر التشوهات المنتشرة في عصرنا الحالي , حيث يتم تسجيل ولاده سنويا من اصل (٧٠٠) ولاده ,و تعد الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق تشوهين ولاديين مميزين و منفصلين و لكنهما يحدثان بشكل متلازم غالبا. وتحدث الشفة الأرنبية و شق سقف الحلق عندما تفشل النسيج الضامه للبنى الجنينية المختلفة بالالتقاء و الاندماج مع بعضها البعض و ينتج الشكل المتعارف عليه من الشفة الأرنبية و شق سقف الحلق من عدم التحام النتوءات الانفية المتوسطة مع نتوءات الفك العلوي و من الممكن ان تكون الشفة الأرنبية احادية او ثنائية الجانب كما يمكن ان يمتد الي النتوء السنخي , كما ان شق سقف الحلق يحدث نتيجة عدم التحام الرفوف الحنكية مع بعضها البعض و مع الحاجز الانفي أو مع الحنك الأولي. (Ye et al, 2009) . تسمى الحالة الشفة الأرنبية (شق الشفة) لان شفه المصاب تكون مشقوقه و لدي العامه يسمونه بالاشرم لان شفاه و انفه يكونوا مشرومين اما من يعاني من شق سقف الحلق فقط (قبة الحنك) فقد كان يعرف بالاختف لان الصوت ينتقل من فمه الي انفه فيخرج من انفه كصوت عميق فيه خنف . (الصبي و اخرون ,٢٠١٩). ان التواصل من خلال الكلام و اللغة فهو طبيعة انسانية تتطور مع التواصل الغير لغوي للطفل من خلال البكاء و الابتسامه الي ان يتضمن جوانب معرفيه و سمعيه و استقبال و ارسال للمعلومات فاستخدام الكلام و اللغة هو المقصود بالتواصل و تطور اللغة يحدث بشكل طبيعي لدي الاطفال الذين لا يعانون من اعاقات و لكن عندما نشك في وجود اي اضطراب فان الحاجه تدعو الي سرعه تشخيصه و علاجه (نزهه امير ,٢٠٠٨).و تؤكد دراسة (صالح بن يحيي الجارالله الغامدي ,لسنة ٢٠٠٩) التي توضح مدي تاثير اضطراب اللغة علي النطق بالنفس لدي الاطفال ولا شك بان الشفة الأرنبية لها دور فى التأثير على اللغة لدى الاطفال مما تسبب لهم ما يسمى باضطرابات اللغة (الحذف و الابدال) .

واللغة هي وسيله الاتصال و التخاطب بين الناس و سبيل التفاهم بينهم حيث يستجيب الاطفال الي اللغة التي ترد الي مسامعهم قبل ان تتولد لديهم القدره علي استخدامها فالرضيع يعجز عن ايصال رسالته لذويه باستخدام اللغة و مفرداتها من الكلمات الا انه يستطيع ان يستخدم حنجرته لاجراج اصوات ترتبط بنغمات خاصه تعبر عما تريد الوصول اليه. (النوايسة و القطاونة,٢٠١٥).

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

واللغة و الكلام من اهم الموضوعات في حياة الفرد و خصوصا في المراحل الاولى من حياته و التي تحدد بدرجة كبيرة قبوله الاجتماعي لان اللغة تعد الوسيلة الاولى للتواصل و التفاعل مع الآخرين و للتعبير عن المعرفة و الافكار و الانفعالات و اي خلل في اللغة او الكلام سيؤثر بشكل سلبي في التواصل و التفاعل و القبول الاجتماعي. فاللغة و الكلام فهي خاصية انسانية فضل الله بها خليقته علي الارض و قد يتعرض الافراد الي اضطرابات اللغة و الكلام و نتيجة لاهمية اللغة في حياة الانسان بدا الاهتمام بها في البحوث و الدراسات الحالية بشكل متزايد .

ففي بعض الاحيان و في الواقع هناك حالات من اطفال الشفة الأرنبية يعانون من فرط النشاط الحركي او ما يعرف باسم فرط النشاط الحركي و هو من اكثر الاضطرابات شيوعا لدي الاطفال و علي وجه التحديد اطفال الشفة الأرنبية و فرط النشاط الحركي تتميز اعراضه بعدم الاستقرار و الحركة الزائدة وعدم الهدوء و الراحة و تظهر مظاهره في كثرة الحركة و تسلق الاشياء المحيطة به و صعوبة الجلوس ساكنا وهو ذلك الطفل الذي يتصف بالعجز في التركيز و عدم القدرة علي انهاء الاعمال التي توكل اليه (عبدالله و اخرون ، ٢٠١٩) . و توضح دراسة (منيره عبد الرحمن منصور لسنة ٢٠١٥) مدي تاثير فرط النشاط الحركي علي الاطفال . ولا شك بان فرط النشاط الحركي يؤثر كثيرا على اللغة عند اطفال الشفة الأرنبية مما يؤدي الى حدوث اضطرابات لغه مثل(الحذف و الابدال).

فرط النشاط الحركي او ما يطلق عليه النشاط الزائد يعد من اكثرالمشكلات السلوكية التي يعاني منها الاطفال و بالاخص طفل الروضة و تعتبر هذه المشكلة او ما يسمى باضطراب فرط النشاط الحركي من اكثر الاضطرابات التي تشكل مصدرا اساسيا لازعاج و ضيق و توتر كل المحيطين بالطفل سواء كان في المنزل او الروضة او النادي او اي مكان يتجمع من حوله اشخاص و مما لاشك فيه ان هذا الاضطراب يؤثر علي مستوي الطفل و علي استجاباته و افعاله و تصرفاته مما ينعكس سلبيا علي استجابات و ردود افعال المحيطين بالطفل و ينعكس ايضا علي اسلوب معاملتهم للطفل ونال هذا الاضطراب اهتمام كثير من الباحثين سواء كان في مجال الطب و بالاخص طب الاطفال او كان في مجال علم النفس او في مجال التربية عامة او التربية الخاصة علي وجه التحديد فاصبح من اكثر الاضطرابات شيوعا في عصرنا الحالي و تناولت المجالات و الكتب و الابحاث من شتي الزوايا فقد اشار البعض علي انه اضطراب عضوي بينما البعض الاخر راي انه اضطراب سلوكي و لذلك تعددت تعاريف اضطراب النشاط الزائد تبعا لرأي الباحثين ، فنجد تعاريف طبية ركزت على الجانب الوراثي الجيني ، كما نجد من عرف الاضطراب تبعا للجانب السلوكي الملاحظ ، خاصة منها الحركات الجسميه ، إلا أن معظم التعريفات تتكامل في الوصف مع بعضها البعض لهذا الاضطراب كما سيتم عرضها لاحقا.

مشكلة الدراسة:-

بدا الاحساس بالمشكلة من خلال العمل فى مراكز التربية الخاصة , حيث وجدت الباحثة ان اطفال الشفه الأرنبية من الطبيعى يكونوا فى الغالب لديهم مشكلات لغويه لكن الباحثة لاحظت بان اطفال الشفه الأرنبية الذين لديهم اضطراب فرط النشاط الحركي يكون لديهم اضطرابات لغويه اعلى مما هو طبيعى مما جعل الباحثة تدفع نحو البحث العلمى لاكتشاف مدى العلاقة بين فرط النشاط الحركى و بعض اضطرابات اللغة (الحذف و الابدال) لدى عينه من اطفال الشفه الأرنبية.حيث يتمثل فرط النشاط الحركى فى انه هو افراط الطفل في الحركة ،وضعف التركيز ، وممارسة حركات عشوائية كثيرة ، وإزعاج من حوله " (بطرس, ٢٠٠٨).

واضطرابات اللغة تشير الى صعوبة في انتاج او استقبال الوحدات اللغوية بغض النظر عن البيئة التي تتراوح في مداها من الغياب الكلي للكلام الي الوجود المتباين في انتاج النحو ,و اللغة المفيدة ,لكن بمحتوي قليل ,و مفردات قليلة و تكوين لفظي محدد,و حذف الادوات و احرف الجر و اشارات الجمع و الظروف.(سيد ٢٠٢٠). بينما الشفه الأرنبية هى تشوة خلقي يصيب كثيرا الجزء الاوسط للوجة و يتظاهر بعدم التحام الاجزاء الرخوة و الصلبة لحركة الفك العلوي و تتوافق بتشوهات اهمها تراجع الفك العلوي و تضيقه كما يلاحظ كثرة حدود الشذوذات السنية , و يعتمد في تشخيصه علي الاطباء المختصين(Bardach, 1990). ومن خلال بحث الباحثة فى الدراسات و البحوث السابقه وجدت خصائص الكلام و النطق عند الاطفال المصابين بالشفه الارنبية و هي :

١) اضطرابات النطق: وهي الاخطاء في مخارج الحروف و اصواتها من حيث مواقعها الطبيعى و قد تكون الاخطاء النطقية المرتبطة بالشفه الأرنبية اما اخطاء ابداليه و هي ابدال حرف مكان حرف اخر مثل استبدال حرف (س) بحرف (ش) . (الصبي و اخرون ,٢٠١٩).

اشكال اضطرابات اللغة هي:

اولا: الابدال : يقصد به ان يبدل الفرد حرفا باخر من حروف الكلمة علي سبيل المثال قد يستبدل الطفل حرف (س) بحرف (ش) او يستبدل حرف (ر) بحرف (و) مرة اخري و هو الاكثر شيوعا عند الاطفال الاصغر سنا و يودي الي خفض قدرة الاخرين علي فهم كلام الطفل عندما يحدث بشكل متكرر.(النوايسة و القطاونة ,٢٠١٥). اوانه هو: ان يحل فونيم ما محل الفونيم او احلال عنصر لغوي محل عنصر لغوي اخر.(سيد ,٢٠٢٠).

ثانيا : الحذف: هو ان يحذف الطفل حرفا او اكثر من الحروف التي تتضمنها الكلمة و من ثم ينطق جزءا من الكلمة فقط و قد يشمل الحذف اصواتا متعددة و بشكل ثابت يصبح كلام الطفل في هذه الحالة غير مفهوم علي الاطلاق حتي للاشخاص الذين يالفون الاستماع اليه كالوالدين و تحدث عيوب الحذف لدي لاطفال الاصغر سنا اكثر من الاطفال الاكبر سنا .(النوايسة و القطاونة,٢٠١٥).

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

وبعد مراجعة الدراسات و الأدبيات و الابحاث تبين للباحثه ازدياد اعداد الاطفال ذوي فرط النشاط الحركي وعلاقته ببعض اضطرابات اللغة(الحذف و الابدال) لدي عينه من اطفال الشفه الأرنبية. و لذلك من خلال عرض المشكله يتضح ان السؤال الرئيسي التي تدور حوله المشكله هو :

الي اي مدي توجد علاقته بين فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة(الحذف و الابدال) عند عينه من اطفال الشفه الأرنبية ؟

و يتفرع من هذا السؤال اسئله فرعية و هي :

١. ما طبيعة العلاقه الارتباطيه بين فرط النشاط الحركي و اضطرابات اللغة عند الاطفال من ذوي الشفه الأرنبية ؟
٢. ما طبيعة العلاقه الارتباطيه بين فرط النشاط الحركي و الحذف عند الاطفال من ذوي الشفه الارنبية ؟
٣. ما طبيعة العلاقه الارتباطيه بين فرط النشاط الحركي و الابدال عند الاطفال من ذوي الشفه الارنبية ؟

اهمية الدراسة:

اولا: الاهمية النظرية :

تتمثل اهمية الدراسه في الجانب النظري فيما يلي :

١. توفر إطاراً نظرياً ودراسات سابقة يمكن الرجوع إليها من قبل الباحثين والمهتمين حول مفاهيم البحث، والمتمثلة في فرط النشاط الحركي و اضطرابات اللغة .
٢. اهمية هذه المرحله العمريه و ما يتعرض له اطفال الشفه الأرنبية من اضطرابات اللغة مثل (الحذف و الابدال).
٣. لقاء النظر علي فرط النشاط الحركي لما له من اهميه كبري لدي اطفال الشفه الأرنبية وتأثيره علي اضطرابات اللغة .

ثانيا : الاهمية التطبيقية

١. تساعد الدراسة المعلمين في التعرف علي اضطرابات اللغة التي تسببها الشفه الأرنبية.
٢. استخلاص نتائج ومقترحات قد تفيد المختصين والمربين نحو الشفه الأرنبية بشكل عام و فرط النشاط الحركي و تأثيره على اضطرابات اللغة(الحذف و الابدال)لدي اطفال الشفه الأرنبية بشكل خاص.
٣. تكشف الدراسه الفروق بين الجنسين في مرحلة الطفوله المبكره لدي اطفال الشفه الأرنبية من حيث الشفه الأرنبية و تأثيرها على اضطرابات اللغة(الحذف و الابدال) .

اهداف الدراسه:

١. كشف علاقه بين فرط النشاط الحركي و بعض اضطرابات اللغه (الحذف و الابدال) لدي عينه من اطفال الشفه الأرنبيه .
٢. التعرف علي طبيعة العلاقه الارتباطيه بين فرط النشاط الحركي و اضطرابات اللغه (الحذف و الابدال) لدي عينه من اطفال الشفه الأرنبيه .

المفاهيم الاجرائية للدراسة:**اولا: مصطلح فرط النشاط الحركي:**

عرفه بطرس حافظ بانه: افراط الطفل في الحركه و ضعف التركيز ،و ممارسة حركات عشوائيه كثيره ،و ازعاج من حوله .(بطرس حافظ ،٢٠٠٨). وعرفه محمد النوري علي انه :هو حركه جسميه مفرطه ،بحيث لا يستطيع الطفل التحكم في حركة الجسم .(محمد النوي القمش ،٢٠٠٧).

التعريف الاجرائي (الباحثه): هو الدرجة التي يحصل عليها الطفل في الابعاد التي يتضمنها مقياس فرط النشاط الحركي .

ثانيا: مصطلح اضطرابات اللغه:

يعرفها الدكتور قحطان احمد : بانها مشاكل الفهم واستخدام اللغه للتواصل مع الاخر سواء كانت هذه اللغه منطوقه او مكتوبه و المتعلقة بالاصوات ،التراكيب ،النمط،القواعد ،الدلاله و السلوك اللفظي يعد شكلا من اشكال التواصل في السياق الاجتماعي.(قحطان احمد ،٢٠١٠). كما عرفتھا ايضا نزھة امير :و هي اخطاء كلاميه تنتج عن اخطاء في حركة الفك و الشفاه و اللسان او عدم تسلسلھا بشكل مناسب (نزھة امير ،٢٠٠٨).

التعريف الاجرائي (الباحثه): هي الدرجة التي يحصل عليها الطفل في الابعاد التي يتضمنها مقياس اضطرابات اللغه .

الحذف: هو ان يحذف الطفل صوتا من الاصوات التي تتضمنها الكلمه ثم ينطق جزءا فقط ، و قد يشمل الحذف اصواتا متعدده و بشكل ثابت فيصبح كلام الطفل في هذه الحاله غير مفهوم علي الاطلاق (نزھة امير ٢٠٠٨) .

الابدال: حيث يتم اصدار صوت غير مناسب بدلا من الصوت المرغوب فية كاستبدال (س) بحرف (ش، ث) او استبدال (ر) بحرف (و) مثال :خوف بدل من خروف و هو ما يعرفه بالشفه ،و تعد عيوب الابدال اكثر شيوعا في كلام الاطفال صغار السن و بين عيوب النطق النمائية (نزھة امير ،٢٠٠٨).

ثالثا: مصطلح الشفه الأرنبيه :

وهو اصابة بالشق منفردا في الحنك او بوجود شق الشفاه الشفه الأرنبيه. او هي فجوه في جلد و عضلات و انف الطفل الشفاه المشقوقه فهي خلقية مما يعني ان الطفل ولد بهذه الحاله.

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

وتشير كلمة شق الي :فتحة او فراغ (مسافة غير وظيفية)،مع اختلاف في الموقع والحجم ،و يعد شق الحنك من اكثر التشوهات الخلقية التي تصيب المنطقة الفموية (مازن زيتاني ،٢٠٠٩).

محددات الدراسة :

اولا:المحددات الموضوعية:

- المتغيرات المستقلة للبحث هي:فرط النشاط الحركي عند الاطفال .
- المتغيرات التابعة للبحث هي :بعض اضطرابات اللغة (كالحدف و الابدال).

ثانيا: المحددات المكانية :

- مراكز التربية الخاصة بمدينة ملوي و مستشفيات اطفال الشقة الارنبية بمحافظة المنيا و مركز ملوي.

الاطار النظري و دراسات سابقة :

اولا : فرط النشاط الحركي :

مظاهر تطور اضطراب فرط النشاط الحركي للطفل :

ان اضطراب فرط النشاط الحركي ليس كباقي الامراض يمكن التخلص منه بالادوية و ليس كبعض الاضطرابات النفسية التي يمكن علاجها بالتحليل النفسي او بالعلاج المعرفي السلوكي انه اضطراب ملازم الفرد طوال مراحل نموه المختلفة و ان اختلفت مظاهرها و خصائصها عبر كل مرحلة من هذه المراحل. فقد اشارت الدراسات الي ان مشكلة فرط النشاط الحركي هي مشكلة طويلة الامد و ان حوالي (٣٠-٧٠٪) من الاطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب سوف يستمر لديهم هذا الاضطراب الي سن المراهقة و احيانا الي سن البلوغ و الرشد(بطرس ،٢٠١٠).

فرط النشاط الحركي هو: اضطراب سلوكي يتم بالحركة الزائدة غير الهادفة و غير المقبولة اجتماعيا و عدم الانتباه و الاندفاعية و يكون هذا السلوك متكرر و شديد بالمقارنة مع سلوك الاطفال العاديين .(احمد ،٢٠١٤).

و فرط النشاط الحركي :هو عبارة عن حركات جسمية تفوق الحد الطبيعي او المقبول و يستطيع المعلم المرشد معرفة ما اذا كانت كمية او درجة النشاط الارادي و غير الارادي عند تلميذهم مختلفة عما هي لدي مجموعة رفاق الولد من الجنس نفسه ,ان النشاط الزائد يظهر من خلال النشاط الغير ملائم و غير الموجة بالمقارنة مع سلوك الولد النشط الذى تتسم فعالياته بانها هادفة و منتجة فالولد لا يستقر ,و هو دائم التجوال في المكان و يتسلق الجدران في مواقف مختلفة ,و كذلك تكرار فشلة في اتمام اية مهمة يكلف بها علي الرغم من شدة نشاطه و كونه نادرا ما يجلس هادئا فهو دائم الحركة .(بيبي ,٢٠٠٠).

ثانيا: اعراض فرط النشاط الحركي :

ويتم التعرف عليه من الاعراض التالية :

١. دائما و ابدأ يتعلم و يتحرك الطفل في مقعده ولا يستطيع الجلوس بوضعا ثابت في مكانه .
 ٢. يظل يمشي في المكان الذي يوجد فيه بشكل مستمر وذلك بدون سبب أو هدف واضح.
 ٣. دائما و ابدأ يجعل المكان الذي يوجد فيه غير منظم او مرتب بل يجعله دائما مكركب.
 ٤. دائما و ابدأ يحدث ضوضاء , ولا يستطيع ممارسة عمله أو نشاطه بهدوء.
 ٥. دائما يتحدث بكثرة وفي موضوعات غير مترابطة وفي بعض الاحيان غير مهمه.(اليوسفي، ٢٠٠٥).
- وهناك من يري ان اعراض فرط النشاط الحركي هي :

١. غالبا يتحدث بشكل مفرط .
٢. يندفع بسرعة كبيرة اثناء تحركه و تنقلة من مكان لآخر .
٣. يجد صعوبة في اللعب او ممارسة الانشطة الترفيهية بهدوء .
٤. يقوم بحركات عصبية بيديه و رجليه .(ابو شوارب، ٢٠١٣).

التشخيص لاضطراب فرط النشاط الحركي :

فرط النشاط الحركي للطفل في الروضة أو في المنزل أو في بيئته الاجتماعية , فالهدف الأساسي من عملية التشخيص هو معرفة جوانب القوة والضعف , وتصنيف مشكلته لتقديم للمعالج الصورة الشاملة للطفل , حيث تشمل عملية التشخيص ما يلي:

(١) اجراء القياس والتشخيص والحصول على معلومات عن حالة الطفل من مصادر متعددة تشمل الأولياء , والمعلمين إضافة إلى السجلات الطبية , والنفسية والاجتماعية , ودراسة الحالة .

(٢) يمكن الحصول على معلومات عن حالة الطفل من مقاييس التقدير الذاتي من المقابلة المباشرة مع الطفل , كما أن الملاحظة المباشرة خلال فترة تطبيق الاختبار تقدم معلومات هامة عن كيفية تعامل الطفل مع الواجبات البسيطة أو المركبة , والتعرف على المشكلات البصرية أو السمعية .

(٣) إن قياس وتشخيص المظاهر السلوكية والانفعالية للطفل من شأنه أن يلقي الضوء عما إذا كانت المشكلات ذات مظاهر خارجية مثل العدوانية اضطرابات التصرف , والقلق , والاكتئاب , والانسحاب الاجتماعي (الزارع , ٢٠٠٧).

تناول العديد من الباحثين مختلف التفسيرات لأسباب اضطراب فرط الحركة غير واضح و هناك عدة عوامل تسبب هذا الاضطراب منها :

(١) الوراثة :و ترجع الي العوامل الجينية و تبين الدراسات وجود علاقة بين العوامل الجينية و مستوي النشاط و قد استخدموا الباحثين طريقتين رئيسيتين للتعرف علي الاسس الجنية للنشاط الزائد و هما:دراسة الاقارب و دراسة التوائم و تشير النتائج الي ان الاطفال اللذين يعانون والدي من النشاط الزائد غالبا ما يكونان قد عانوا من الاضطراب ذاتة في طفولتهما .

(٢) **العوامل البيولوجية:** مثل خلل في وظائف المخ و المراكز المسؤولة عن الانتباه او خلل كيميائي للناقلات العصبية في المخ ففي الدماغ خلايا عصبية لا تلتصق ببعضها لأن بينها مسافات صغيرة جداً، أما لدى هؤلاء الأطفال فهناك احتكاك في الخلايا العصبية لعدم وجود القنوات التي تفصل بين المرسلات مما يجعل الرسائل في أذهانهم مشوشة وغير واضحة، كذلك وجود خلل في إنتاج الدوبامين في القشرة الأمامية منطقة العمليات المعرفية مثل التركيز والانتباه لذا تكون مناطق الدماغ التي تسيطر على الانتباه أقل نشاطاً، كذلك مستوى الجلوكوز في الدماغ لدى هؤلاء الأطفال يكون أقل، وحجم الدماغ أصغر ب ٦٪ في الأطفال الذين لديهم اضطراب النشاط الزائد عن غيرهم من الأطفال بدون نشاط، وترجح بعض النظريات أن سبب الاضطراب هو تأخر نضج بعض مناطق الجهاز العصبي يشهد لهذا أن بعض الأطفال يتحسنون مع مرور الوقت عندما يكون جهازهم العصبي أكثر نضجاً . (Carol&Lensch,2000).

(٣) **النمو العقلي:** قد ينتج نتيجة نقص في ذكاء الطفل حيث يؤثر النمو العقلي علي كفاءة الانتباه لدي الاطفال .

(٤) **العوامل البيئية :** مثل تعرض الام اثناء الحمل الي الاشعاع او العقاقير الطبية او المخدرات او الكحول او الدخان او تعرضها للأمراض المعدية مثل الزهري أو الحصبة الألمانية وغيرها يؤدي إلى تلف بالمخ مراكز الانتباه ، أو التعقيدات المبكرة عند الولادة . كذلك تعرض الطفل إلى أي حادث في مرحلة الطفولة المبكرة أو وقوعه من مكان مرتفع مثل هذه الحوادث قد تصيب بعض المراكز العصبية في المخ المسؤولة عن التركيز والانتباه ، كذلك التسمم بالرصاص الذي يدخل في طلاء لعب الأطفال (Mayes & Calhoun& Crowell . 2000). وأكدت الدراسات ان والدين الاطفال ذوي اضطراب فرط النشاط الحركي اكثر استخداما للاوامر و اساليب العقاب البدني و اقل دعما لابنائهم و اكثر سلبية و اقل مرونة و استخداما لاساليب المكافاة والثواب (Harvey et al, 2003) .

(٥) **العوامل النفسية و الاجتماعية :** ان الاطفال الذين يعيشون في مؤسسات اجتماعية و اطفال الاسر غير المستقرة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية هم اكثر عرضة للنشاط الزائد كذلك سوء المعاملة من الوالدين والإهمال والعقاب البدني أو النفسي الشديد والحرمان العاطفي لها دور كبير، كذلك قد يترسب الاضطراب بدخول الطفل إلى المدرسة وانتقاله إلى بيئة جديدة ، وهذا أيضاً لا يعني أن كل الأطفال من البيوت غير المستقرة قد تصاب بهذا الاضطراب .

هرمونات الغدة الدرقية: لقد وجد بعض الأطباء في ماريلاند هناك علاقة ايجابية بين مستويات هرمونات الغدة الدرقية و النشاط الزائد حيث ان الزيادة في افراز هذه الهرمونات تؤدي الي النشاط الزائد (سيسالم، ٢٠٠١).

علاج اضطراب فرط النشاط الحركي لدي الاطفال :

توجد وسائل مختلفة يمكن استخدامها لمساعدة الاطفال ذوي فرط النشاط الحركي نظرا لاختلاف اسباب هذا الاضطراب و اختلاف توجيهات المهتمين و العاملين مع هؤلاء الاطفال و تشمل هذه الوسائل :

اولا:العلاج بالعقاقير:

يتم استخدام بعض الادوية في علاج هذا الاضطراب من اشهرها ريتالين (Ritalin) حيث يودي العلاج بالادوية الي خفض الحركة المفرطة لدي الطفل و تهدى من تصرفاته و تحسن مستوي انتباهه ولكن لا تحسن من علاقات الطفل الاجتماعية مع من حوله اضافة الي ان لها اثار جانبية سلبية علي صحة الطفل مثل نقص الوزن و نقص الطول و زيادة معدل النبض و ارتفاع ضغط الدم (علاونة ، ٢٠٠٤).

كذلك يستغرق استخدام هذه الادوية عدة اشهر حتي تعيد تنشيط التوازن في خلايا المخ لدي الطفل و يتوقف طول مدة العلاج علي حدة الاضطراب و علي الجرعة المستخدمة (فراج ، ٢٠٠٤).

وبشكل عام فان المويدين لاستخدام العقاقير يرون ان العقاقير المستخدمة في العلاج تساعد الطفل علي الاستقرار و اداء واجباته و تخفيف من حدة التوتر و القلق لديه و تقلل من مستوي نشاطه الحركي و الاندفاعي و يؤكد ذلك دراسة قام بها (باتسون و سيمون) حيث يؤكدان ان باستخدام عقار الميثيل فينيديت يفيد في خفض الاعراض السلوكية الاساسية لهذا الاضطراب . (Batson & Simone, 2002)

و لكن المعارضون لاستخدام هذه العقاقير يرون ان تاثير هذه العقاقير سلبى من حيث انه لا يحسن من القدرة علي التعلم و التحصيل الاكاديمي للطفل كذلك لا يحسن من سلوكه الاجتماعي هذا بالاضافة الي امكانية ان يصبح الطفل مدمن علي استخدامها بالاضافة الي تاثيراتها الجانبية مثل صعوبات النوم ، الصداع ، التقلص الحركي و العضلي و نقص الشهية و احتمالية انخفاض معدل النمو و خطر الاصابة بالتشنجات اللاارادية (الحمد ، ٢٠١٠).

ثانيا :العلاج السلوكي :

يعد العلاج السلوكي احد الاساليب الحديثة المتبعة في العلاج و هو يعتمد علي نظرية التعلم و يشتمل علي العديد من فنيات العلاج التي هدفها اجراء تغيير فعال علي سلوك الطفل. ان الهدف الرئيسي للعلاج السلوكي هو زيادة انماط السلوك المرغوبة و تقليل انماط السلوك الغير مرغوبة و ذلك من اجل تحقيق مزيد من التوافق بين الافراد و بيئاتهم الاجتماعية و يتم تعديل السلوك من خلال اعادة تنظيم الظروف و المتغيرات البيئية ذات العلاقة بالسلوك (بطرس، ٢٠١٠).

يمتاز العلاج السلوكي بفاعليته في العلاج و كذلك استمراريته كما يمتاز بتعدد اساليبه و يمتاز بسهولة تطبيقه و قلة اثاره الجانبية اذ ما قورن بالعلاج بالعقاقير كذلك بانه يمتاز بانه يستخدم في جميع المراحل العمرية (يوسف ، ٢٠٠٠). و يوجد عدة طرق تهتم بتعديل السلوك و هي ذات جدوي مع الاطفال ذوي فرط النشاط الحركي و تشمل :

التعزيز الايجابي:

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

حيث يتم تعزيز السلوك الجيد لدى الطفل و تقديم المكافآت او الهديا كلما قام بسلوك جيد و التعزيز يودي الي دفع الفرد الي تكرار السلوك(ملحم , ٢٠١٠).

تكلفة الاستجابة :

في هذه الحالة يحصل الطفل علي نقاط عندما يظهر السلوك الايجابي المناسب و يخسر نقاط عندما يظهر سلوكيات سلبية غير مناسبة و يمكن للطفل استبدال النقاط التي يحصل عليها من خلال جدول بقيمة المعززات التي يمكن الحصول عليها حسب كل معزز ما يملك الطفل من نقاط و تتم من خلال استخدام العقاب ك فقدان المعززات نتيجة للسلوك غير المرغوب (حسين , ٢٠١٠).

ثالثا: الارشاد السلوكي :

يكتسب هذا السلوك لانة يعتمد علي تدريب و تعليم الوالدين باعتبارهما اكثر الاشخاص اهتماما و ملاحظة لسلوك الطفل و ذلك باستخدام اسلوب الثواب و العقاب مع الطفل مما يشجعة علي تغير سلوكه و ايضا باستخدام تدريبات التحكم في الذات و تنمية ملاحظة الطفل لنفسه و توجيهها (المهدي, ٢٠١٠). كذلك يتضمن هذا الاسلوب تعليم الوالدين و المعلمين كيف ملاحظة سلوك الطفل و كيفية ارشادهم لكي يتمكنوا من التعامل مع الطفل بطريقة صحيحة و اكتشاف المشكلة لدي الطفل ذوي فرط النشاط الحركي و مساعدته علي اتباع القواعد و كيفية التحكم في الغضب و التفكير قبل القيام باي سلوك و مساعدتهم علي تنمية علاقاتهم و توفير الخبرات لتعليمهم كيفية زيادة كفاءة الذات (القاضي , ٢٠١١).

رابعا :العلاج الاسري:

ان وجود طفل يعاني من اضطراب ADHD يسبب التوتر داخل الاسرة و يؤثر علي العلاقات الاسرية كما ان فشل الوالدين في التعامل مع طفلهم المصاب قد يودي الي الوالدين بالاكتئاب و القلق لذا كان من الضروري تقديم العلاج الاسري للوالدين حتي يتمكن الوالدين من تنظيم سلوك طفلهم كذلك مساعدتهم علي التكيف مع الضغط الناتج مع وجود طفل مصاب بهذا الاضطراب داخل الاسرة .

لذا وضع(باترسون Patterson) برنامجا يتعلم فيه الوالدان المبادي الاساسية للتدعيم الايجابي و كيف يتجاهل السلوكيات السلبية و هذا النوع من التدخل يركز علي تعليم الوالدين استراتيجيات جديدة حتي يساعدوا اطفالهم علي التغلب علي اعراض فرط النشاط الحركي حيث يتم تعليم الوالدين ملاحظة السلوك الايجابي للطفل و تعزيزه و عدم التركيز علي السلوك السلبي و يتم تشجيع الطفل علي القيام بسلوكيات ايجابية و يقوم بتعيمها (مصطفي , ٢٠١١).

خامسا :نظام التغذية :

تستند هذه الطريقة الي ان الالوان الصناعية و بعض مكتسبات الطعم و السكاكر قد تلعب دورا هاما في حدوث اضطراب فرط النشاط الحركي لدي الاطفال و يتضمن العلاج بالتغذية علي استبعاد هذه المواد

من غذاء الطفل و ينادي بعض المتخصصين باستبدال هذه المواد بمواد اخري طبيعية و بايجاد بدائل للطفل حتي لا يشعر بالحرمان من كل ما يحب من الاطعمة (بطرس ، ٢٠١٠).

سادسا : تكيف بيئة الطفل :

ان بيئة الطفل تلعب دورا اساسيا في حدوث اضطراب فرط النشاط الحركي لذا فان هذا النوع من العلاج يركز علي الاقلال من المثيرات البيئية التي من الممكن ان تزيد من حدة هذا الاضطراب. لذا اشارت الدراسات الي انة من الضروري تكيف و تنظيم بيئة الطفل المصاب بهذا الاضطراب فمثلا يجب ان يسمح لهؤلاء الاطفال الجري و الحركة في الحدائق العامة او في مساحات واسعة و خالية حتي نساعدهم علي استغلال طاقتهم في انشطة ترفيهية كما يجب علي القائمين علي العملية التربوية العمل علي توفير نوع من الدراسة الخاصة لهؤلاء الاطفال و تجهيز قاعة الدرس بالامكانيات التي تناسبهم بحيث تبتعد عن كل ما يسبب تشتت انتباه الطفل من ضوضاء و مؤثرات خارجية كما تكون القاعات واسعة حيث ان معظم هؤلاء الاطفال يقلقون من مجرد وجودهم في اماكن ضيقة (بطرس، ٢٠١٠).

كذلك ان نضع لهم العاب من مواد غير قابلة للكسر و ان تكون فصولهم الدراسية بعيدة عن مناطق الضوضاء و ان تكون جيدة الاضاءة و التهوية و يتوفر بها اثاث مريح للطفل حتي يخفف من تملله و كثرة تحركة (القاضي ، ٢٠١١). ويتم عمل برامج علاجية ابداعية في هذه البرامج حيث يتم تفاعل الاطفال ذوي اضطراب فرط النشاط الحركي مع بعضهم اتلبعض في المخيمات الصيفية و كذلك يقوم الاطفال بممارسة الرياضة و نشاطات متعددة بالاضافة الي التدخل السلوكي من خلال هذه البرامج و تستمر هذه البرامج لعدة اسابيع و تتضمن كذلك التدريب علي المهارات الاجتماعية بالاضافة الي مجموعات اللعب (Kring 2002 , Davison, Neale & ,).

تعقيب الباحثة علي محور فرط النشاط الحركي :

من خلال كل ما تم عرضه سابقا يوضح مدي اهمية و خطورة اضطراب فرط النشاط الحركي علي الاطفال و مدى تزايد النسب المصابة به مما جعلها تجعله عنصر اساسي في دراستها للبحث عنه لطريقة للتعامل معه مما يجعله لا يؤثر سلبا علي الاطفال .

ثانيا : اضطرابات اللغة:

اللغة: هي وسيلة الاتصال و التخاطب بين الناس و سبيل التفاهم بينهم حيث يستجيب الاطفال الي اللغة التي ترد الي مسامعهم قبل ان تتولد لديهم القدرة علي استخدامها فالرضيع يعجز عن ايصال رسالته لذوية باستخدام اللغة و مفرداتها من الكلمات الا انه يستطيع ان يستخدم حنجرته لاجراخ اصوات ترتبط بنغمات خاصة تعبر عما تريد الوصول اليه (النوايسة و القطاونة، ٢٠١٥). واللغة و الكلام من اهم الموضوعات في حياة الفرد و خصوصا في المراحل الاولى من حياة و التي تحدد بدرجة كبيرة قبولة الاجتماعي لان اللغة تعد الوسيلة الاولى للتواصل و التفاعل مع الاخرين و للتعبير عن المعرفة و الافكار و الانفعالات و اي خلل في اللغة او الكلام سيؤثر بشكل سلبي في التواصل و التفاعل و القبول الاجتماعي . فاللغة والكلام فهي خاصية

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

انسانية فضل الله بها خليقة علي الارض و قد يتعرض الافراد الي اضطرابات اللغة والكلام و نتيجة لاهمية اللغة في حياة الانسان بدا الاهتمام بها .

ولكن لابد ان نفرق بين مصطلحات اللغة و الكلام و التواصل :

١. اللغة : مفهوم كبير يشمل كل ما يحيط بنا من مثيرات لانها تدلل علي لغة .
- او هي عملية معقدة و جهاز ديناميكي برموز متفق عليها تستخدم باساليب متعددة للتواصل ولا تتفصل اي لغة في العالم من التراث الثقافي و الاجتماعي و التاريخي كما ان لكل لغة مكونات تتعلق بالجانب الصوتي و النحوي و الصرفي و الدلالي و السياق الاجتماعي (البراجماتي) . (الظاهر , ٢٠١٠) .
- و هناك العديد من التعريفات الاخرى للغة التي اجتهد العلماء في وضعها , نذكر منها الاتي :-
- يري (شايبير) ان اللغة :هي عبارة عن طريقة انسانية و متعلمه لايصال الافكار و الانفعالات و الرغبات بواسطه نظام معين من الرموز اختارها افراد مجتمع ما و اتفقوا عليه (النوايسة و القطاونة, ٢٠١٥) .
- هي نظام من الاستجابات تساعد الفرد علي الاتصال بغيره من الافراد اي ان اللغة تحقق وظيفة الاتصال بين الافراد بكافة ابعاد عملية الاتصال و جوانبها (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .
- و هناك من يعرفها علي انها : قدرة ذهنية تتكون من مجموعه المعارف اللغوية بما فيها المعاني و المفردات و الاصوات و القواعد التي تنظمها جميعا و هذه القدرة تكتسب ولا تولد معه , و انما يولد الطفل و لديه استعداد فطري لاكتسابها (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .
- عرف كراشلي اللغة البشرية بانها: التعبير عن المشاعر و الافكار و كذلك استقبالها عن طريق الرموز اللفظية و هو بذلك يكون قد وحد بين اللغة البشرية و بين الكلام (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .
- و نذكر ايضا تعريف كلا من الكلام و التواصل و هما :
- اما الكلام :فهو وسيلة التواصل الاساسية و التي تتطلب سلوكا حركيا و تناسقا عضليا عصبيا دقيقا حيث تتحدد اصوات الكلام بطرق مختلفة لتكون اللغة .
- و هناك عناصر اساسية تؤثر في عملية الاستقبال و فهم مضمون الرسالة و هما :
- نوعية الصوت (quality) .
- السرعة (rate) .
- النبرة (intonation) .
- اما التواصل هو :العملية التي تشتمل علي اللغة و الكلام و تتضمن عملية التواصل عناصر ثلاث هي المرسل و المستقبل و الرسالة التي تتطلب تغذية راجعة . (الظاهر , ٢٠١٠) .
- مكونات اللغة :
- الصوتيات .

• المقاطع.

• التراكيب و الصيغ.

• الدلالات.

- طبيعة اللغة :-

- أولا : تمثل اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموعة المعارف اللغوية التي تتداخل في تكوينها عوامل

فسيولوجية و المتمثلة في المخ و تركيب الاذن و الجهاز الصوتي و العصبي لدى الانسان .

- ثانيا : ان هذه القدرة تهى لدى الانسان الاستعداد الفطري لاكتسابها .

- ثالثا : ان هذه القدرة المكتسبة تتمثل في نسق متعارف على بين افراد امة ما، حيث يطلق عليها

الجماعة اللغوية الناطقة بلغة ما .

-رابعاً: تعد اللغة اداة يتواصل فيها افراد مجتمع معين .(النوايسة و القطاونة ، ٢٠١٥).

• اضطرابات النطق : هي اخطاء كلامية تنتج عن اخطاء في حركة الفك و الشفاة و اللسان او عدم

تسلسلها بشكل مناسب بحيث يحدث استبدال او حذف او اضافة او تشوية .(النوايسة و القطاونة

، ٢٠١٥).

تعد عيوب النطق حتي الان اكثر اشكال اضطرابات الكلام شيوعا و من ثم نكون الغالبية العظمي

من حالات اضطرابات النطق التي يمكن ان نواجهها في افصول الدراسية او في المراكز العلاجية و بذلك فان

اضطرابات النطق تتمثل في اربعة اشكال و هي :

• اشكال اضطرابات النطق هي:

• أولا: الابدال substitution : يقصد به ان يبدل الفرد حرفا باخر من حروف الكلمة علي سبيل

المثال قد يستبدل الطفل حرف (س) بحرف (ش) او يستبدل حرف (ر) بحرف (و) مرة اخري و

هو الاكثر شيوعا عند الاطفال الاصغر سنا و يؤدي الي خفض قدرة الاخرين علي فهم كلام الطفل

عندما يحدث بشكل متكرر .(النوايسة و القطاونة ، ٢٠١٥).

او انه هو: ان يحل فونيم ما محل الفونيم او احلال عنصر لغوي محل عنصر لغوي اخر .(سيد

، ٢٠٢٠).

• ثانيا : الحذف omission: هو ان يحذف الطفل حرفا او اكثر من الحروف التي تتضمنها الكلمة

و من ثم ينطق جزءا من الكلمة فقط و قد يشمل الحذف اصواتا متعددة و بشكل ثابت يصبح كلام

الطفل في هذه الحالة غير مفهوم علي الاطلاق حتي للاشخاص الذين يالفون الاستماع الية كالوالدين

و تحدث عيوب الحذف لدي لاطفال الاصغر سنا اكثر من الاطفال الاكبر سنا .(النوايسة و

القطاونة، ٢٠١٥).

او هو: حذف عنصر لغوي من التركيب او حذف قطعة لغوية من الوحدة اللغوية ، او انه عدم انتاج

وحدة لغوية كان يجب انتاجها .(سيد ، ٢٠٢٠).

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

- **ثالثا : التحريف او التشوية distortion :** يقصد بذلك ان ينطق الطفل الكلمات بطريقة مألوفة في مجتمع ما اي ينطق الطفل جميع الاصوات التي ينطقها الاشخاص العاديون لكن بصورة غير سليمة المخارج عند مقارنتها باللفظ السليم حيث يبعد الصوت عن مكان اللفظ السليم .(النوايسة و القطاونة, ٢٠١٥).
- **او يعرف بأنه :** هو نطق الصوت بطريقة خاطئة ,حيث يفقد الصوت احدي خصائصه المميزة او اكثر وقد يكون الصوت المبدل الية قريبا من الصوت الهدف و لكن نقطة او لفظة ليس طبيعيا ,كما انه غير مميز بملامح صوتية مدركة في نظام اللغة الصوتي, فيصعب بذلك تمييزه او مطابقته مع صوت الهدف ,ولا يسمى هذا ابدالاً بالرغم من ابدال الصوت المرغوب في نقطة بغيره .(سيد, ٢٠٢٠).
- **رابعا :الإضافة addition :** هو ان يضيف الطفل حرفا جديدا الي الكلمة المنطوقة مما يجعل كلمة غير واضح و غير مفهوم . (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥).
- **او انه:** خطأ قوامية زيادة عنصر لغوي علي التركيب او اقام فونيم لغوي جديد الي الكلمة .(سيد, ٢٠٢٠).
- **خامسا : القلب المكاني الصوتي metathesis:** هو تغير موضع الوحدة اللغوية في التعاقب سوء في الصوت و المقطع و الكلمة الخ .(سيد , ٢٠٢٠).
- **اما اضطرابات الكلام فهي :** اضطرابات انتاج الكلام و التي تتضمن اضطرابات النطق ,و اضطرابات الصوت ,اضطرابات انسيابية الكلام (الطلاقة stuttering). (الظاهر , ٢٠١٠).
- **اسباب تاخر النطق :** علي الرغم من ان معظم الاطفال في العام الثاني من العمر لديهم المقدرة علي نطق الكلمات او الجمل البسيطة الا ان البعض منهم قد يتاخر عن النطق لاسباب التالية :-
- **قد يكون تاخر الكلام عند الطفل حتي بلوغ العامين او اكثر** امرا طبيعيا بالنسبة للاشخاص الآخرين .
- **وجود نقص** في خلايا الدماغ نتيجة للعوامل الوراثية او عوامل مرضية مثل التهاب السحايا او التهاب المخ .
- **الصمم :** حتي يتعلم الطفل الكلام لابد ان يكون سمعة طبيعيا فاذا كانت درجة الصمم عند الطفل شديدة لم يستطيع النطق .
- **عدم قدرة** الطفل علي تحريك لسانه بسبب وجود رباط عضلي يربط لسان الطفل بقاعد الفم السفلي من الفم مما يمنع حركة اللسان بحرية .(النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥).
- **اضطرابات اللغة :-** يقصد بها تلك الاضطرابات المتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن ظهورها او تاخيرها او سوء تركيبها من حيث معناها و قواعدها او صعوبة قراءتها و كتابتها . (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥).

وتعرف ايضا الاضطرابات اللغوية علي انها :صعوبة في انتاج او استقبال الوحدات اللغوية بغض النظر عن البيئة التي تتراوح في مداها من الغياب الكلي للكلام الي الوجود المتباين في انتاج النحو ,و اللغة المفيدة ,لكن بمحتوي قليل ,و مفردات قليلة و تكوين لفظي محدد,و حذف الادوات و احرف الجر و اشارات الجمع و الظروف.(سيد , ٢٠٢٠).

• **اضطرابات اللغة هي:** مشاكل الفهم و استخدام اللغة للتواصل مع الاخر سواء كانت هذه اللغة منطوقة او مكتوبة و المتعلقة بالاصوات ,و التراكيب,النمط (القواعد),الدلالة ,السلوك اللفظي (الذي يعد شكلا من اشكال التواصل) في السياق الاجتماعي والذي يطلق عليه (pragmatism).(الظاهر , ٢٠١٠).

والتاخر اللغوي له عدة مظاهر وهي :

- **مظاهر اضطرابات اللغة :**
- تاخر ظهور اللغة .
- فقدان القدرة علي فهم اللغة و اصدارها او ما يطلق عليه اقيريا .
- صعوبة الكتابة .
- صعوبة التذكير و التعبير .
- صعوبة فهم الكلمات و الجمل .
- عسر او صعوبة القراءة (الديسليكسيا) .
- صعوبة تركيب الجملة او ما يطلق عليه عيوب اللغة .(النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .

و فيما يلي عرض لاهم انواع اضطرابات اللغة :-

(١) **التاخر اللغوي :** يعرف القصور او العجز اللغوي بانه قصور في تنظيم و تركيب الكلام و التحدث بجمل غير مفيدة و استخدام الكلمات و الافعال و الضمائر في اماكن غير مناسبة لها فقد يضع الفعل مكان الفاعل او المونث مكان المذكر او الضمير المتكلم مكان الغائب و هكذا .(النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥).

والتاخر اللغوي يشير الي تاخر في نمو مهارات اللغة بحيث تكون غير متناسقة مع العمر الزمني للفرد الامر الذي يعيق تواصله مع اقرانه,و قد يوتر ذلك في تكيفه الاجتماعي , و قبولة من الاخرين .(الظاهر , ٢٠١٠).

(٢) **الحبسة الكلامية :** يشير الي خلل او اضطراب او ضعف في احد جانبي اللغة (الاستعاب و الانتاج) او كلاهما و ينتج هذا الاضطراب عن خلل يصيب مراكز اللغة في الدماغ كجرح في الراس او اورام في الدماغ او الجلطة و ارتفاع درجة الحرارة في جسم المصاب و حتي تعتبر الحالة حبسة كلامية يجب ان تكون الاصابة قد حدثت بعد اكتمال نمو اللغة .

(٣) **صعوبة الكتابة :-** وهي لا يستطيع الطفل ان يكتب بشكل صحيح المادة المطلوبة كتابتها و المتوقع كتابتها ممن هم في عمرة الزمني .

(٤) **صعوبة القراءة :-** لا يستطيع الطفل ان يقرأ بشكل صحيح المادة المكتوبة و المتوقع قراءتها ممن هم في عمرة الزمني .

(٥) **صعوبة فهم الكلمات او الجمل :-** يقصد بها صعوبة فهم معني الكلمة او الجملة المسموعة و يقوم بتكرار الطفل استعمال الكلمة او الجملة دون فهمها .

(٦) **صعوبة التذكر و التعبير :-** و هو صعوبة تذكر الكلمة المناسبة في المكان المناسب و من ثم التعبير عنها .

(٧) **صعوبة تركيب الجملة :-** و هو صعوبة تركيب كلمات الجملة من حيث قواعد اللغة و معناها لتعطي المعني الصحيح و في هذه الحالة يعاني الطفل من صعوبة الكلمة المناسبة في المكان المناسب . (النوايسة و القطاونة, ٢٠١٥) .

• اسباب الاضطرابات اللغوية :

اضطرابات اللغة قد تتاثر بالعوامل الجسمية و النفسية و الفيزيولوجية و الاجتماعية و البيئية و بالاعاقات المصاحبة لهذه الاضطرابات و هذه الاسباب تتلخص فيما يلي وهي اسباب اضطرابات النطق و اللغة :-

(١) **الاسباب العضوية :** و تكون مرتبطة بسلامة الاجهزة العضوية المسؤولة عن اصدار الاصوات و نطقها مثل الحنجرة و مزمار الحلق و الفكين و الانف و شق الشفة و الشفة الارنبية و مشكلات اللسانو عدم تناسق الاسنان و عدم تطابق الفكين و خلل الجهاز العصبي المركزي و خلل جهاز السمع و بذلك اي خلل في سلامة الاجهزة المسؤولة عن النطق و اللغة يؤدي الي خلل واضح في سلامة اللغة و خلوها من الاضطرابات.

(٢) **الاسباب الوظيفية :** وهي لا ترجع لوجود خلل عضوي و انما تكون بسبب :

- التعلم الخاطي سواء في البيت او المدرسة او البيئة .
- عدم التوافق العاطفي و الحرمان الثقافي .
- عدم تشجيع الطفل و ضعف رغبة الطفل في الانجاز .
- القلق و الاحباط في عملية الكلام .
- الجو الاسري , التقليد و المحاكاة ,تقبل الاسرة لكلام الطفل الخاطي و اساليب العقاب باشكالة و خصوصا الجسدي كل هذا لهو تاثير كبير جدا علي اللغة عند الطفل .(النوايسة و القطاونة, ٢٠١٥).
- **الاسباب العصبية :** وهي الاسباب المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي او ما يصيبه من تلف او اصابة قبل او بعد او اثناء الولادة فتلك الجهاز هو المسؤول عن النطق و اللغة و تظهر الاضطرابات بشكل واضح لدي الاطفال المصابة بسقف الحلق المشقوق حيث يواجة صاحبة مشكلة في نطق الحروف مثل (ج, ل ,ت , ط , د , ب , ف) .

- **الاسباب المرتبطة بالاعاقات الاخرى:** فمثلا ظاهرة تاخر ظهور اللغة , و التوقف اثناء الكلام , الكلام بصوت غير مسموع , التأتاة , الفافاة , السرعة الزائدة اثناء الكلام , الاضافة , الابدال .

- **وهناك اسباب اخرى ترجع الي اصابة الجهاز الحسي وهي :**

١. عدم قدرة الفرد علي السمع .
٢. عدم قدرة الفرد علي تمييز الاصوات .
٣. ضعف البصر او فقدان . (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .
٤. **الاسباب النفسية :** كالقلق و التوتر وعدم الثقة بالنفس و عدم الشعور بالامان .
٥. **الاسباب البيئية :** وهي تلك التي يعيشها الطفل فهي تؤثر علي تطور الطفل . (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .
٦. **الاسباب السمعية :** فهي مهمة و تؤثر علي الاصوات اللغوية للطفل .
٧. **التخلف العقلي :** وهو ذلك المتمثل في ضعف الذكاء و تركيز الانتباه .
٨. **الاسباب النفسية :** كالقلق و الصراع والصدمات و المخاوف . (النوايسة و القطاونة , ٢٠١٥) .

تعقيب الباحثه علي محور اضطرابات اللغة :

من خلال كل ما تم عرضه فيما يعود علي محور اضطرابات اللغة تؤكد مدي اهميتها و مدي تاثيرها علي الطفل و علي طرق تعامله مع الاخرين مما جعل الباحثه تهتم بان تكون اضطرابات اللغة محور اساسي في بحثها للبحث عن طرق و حلول جديد للتعمل مع اضطراب اللغة عند الطفل .

ثالثا: الشفة الارنبية:

تعد الشفة الارنبية من اشهر التشوهات المنتشرة في عصرنا الحالي , حيث يتم تسجيل ولادة سنويا من اصل (٧٠٠) ولادة , و تعد الشفة الارنبية و شق سقف الحلق تشوهين ولاديين مميزين و منفصلين و لكنهما يحدثان بشكل متلازم غالبا . وتحدث الشفة الارنبية و شق سقف الحلق عندما تقشل النسيج الضامة للبني الجنينية المختلفة بالالتقاء و الاندماج مع بعضها البعض و ينتج الشكل المتعارف عليه من الشفة الارنبية و شق سقف الحلق من عدم التحام النتوءات الانفية المتوسطة مع نتوءات الفك العلوي و من الممكن ان تكون الشفة الارنبية احادية او ثنائية الجانب كما يمكن ان يمتد الي النتوء السنخي , كما ان شق سقف الحلق يحدث نتيجة عدم التحام الرفوف الحنكية مع بعضها البعض و مع الحاجز الانفي أو مع الحنك الأولي . (Ye et al, 2009) .

تسمى الحالة الشفة الارنبية (شق الشفة) لان شفة المصاب تكون مشقوقة و لدي العامه يسمونه بالاشرم لان شفة و انفة يكونوا مشرومين اما من يعاني من شق سقف الحلق فقط (قبة الحنك) فقد كان يعرف بالاخنف لان الصوت ينتقل من فمه الي انفه فيخرج من انفه كصوت عميق فيه خنف . (الصبي و اخرون , ٢٠١٩) .

وهناك بعض التعريفات التي وضعت لمسمياتها و منها :

شق: وهي مسافة غير وظيفية او فراغ بين جهتين مع اختلاف في الموقع و الحجم ,يحدث التشوة عند خطوط الالتحام اثناء الحياة الجنينية ,وقد يتناول الانسجة الرجوة فقط و الانسجة الصلبة للفك العلوي .(Berlowitz , 1996).

الشق السنخي: الشق الذي يحدث بين البني العظمي للفك العلوي في المنطقة الامامية من السنخ و يتجلى بعدم استمرارية النتوء السنخي للفك العلوي بين الرباعية و الناب (Berlowitz, 1996).

و هناك تعريف اخر هو : تشوة خلقي يصيب كثيرا الجزء الاوسط للوجة و يتظاهر بعدم التحام الاجزاء الرخوة و الصلبة لحركة الفك العلوي و تتوافق بتشوهات اهمها تراجع الفك العلوي و تضيقه كما يلاحظ كثرة حدود الشذوذات السنية , و يعتمد في تشخيصه علي الاطباء المختصين (Bardach, 1990).

ونستنتج من كل هذه التعريفات ان :

الشفة الارنبية هي: عيب خلقي او تشوه خلقي يولد به الطفل و يكون خاص بمنطقة الانف و الفم و يؤثر علي مظهر او شكل الطفل العام و الخارجي للطفل لانه يتمثل في انشقاق الشفة العلوية من الفم و الانف ايضا في وجه الطفل.

العوامل المسببة لحدوث الاصابة بالشفة الارنبية :

- تحدث نتيجة فشل اندماج النتوءات الانفية الوجهية خلال الفترة الاولى في تكوين الجنين اي خلال الثلاثة اشهر الاولى من حياة الجنين و لذلك تعتبر من ضمن التشوهات الخلقية .
- **العوامل الوراثية:** في حالة وجود فرد من افراد العائلة مصابا فاحتمالية تكرار الاصابة يكون مرتفع بسبب وجود التاريخ الوراثي في تلك العائلة.
- **العوامل البيئية :** وهناك اعراض كثيرة في البيئة المحيطة منها ما يلي :
 - (١) تعرض الام للاشعة الكثيرة خلال فترة الحمل .
 - (٢) اصابة الام بسكري الحمل و عدم اهتمامها بالعلاج .
 - (٣) الاصابة بالحمي الشديدة .
 - (٤) تناول بعض المهدئات و المسكنات و المضادات الحيوية خلال فترة الحمل و خصوصا بدون استشارة الطبيب .
 - (٥) تعاطي الكورتيزون خلال فترة الحمل الاولى .
 - (٦) تناول الادوية المعالجة لمرض الصرع خلال فترة الحمل مثل الفينيتون .
 - (٧) ممارسة التدخين خلال فترة الحمل تزيد من نسبة الاصابة .
 - (٨) تناول الكحوليات و المخدرات .
 - (٩) تعاطي فيتامين (a) و بكميات عالية .
 - (١٠) عدم تناول حمض الفوليك اثناء الحمل .(الصبي و اخرون ,٢٠١٩).

نسبة انتشار الاصابة بالشفة الارنبية :

الشفة الارنبية و شق سقف الحلق احد العيوب الخلقية المنتشرة في البلاد العربية :

- نسبة حدوثها بصفة عامة طفل واحد من كل الف ولادة طفل .
- نسبة التكرار للاصابة بها ٥ % و قد تتزايد النسبة مع زيادة عدد الحالات في العائلة الواحدة .
- اغلب الحالات وقد يكون نصفها فيها شفة ارنبية و شق سقف الحلق معا .
- في ٢٥ % من الحالات تكون الاصابة بها منفردة فتكون الشفة الارنبية منفردة او شق سقف الحلق منفردا .
- تكون نسبة الاصابة بالشفة الارنبية اعلي لدي الذكر منها لدي الاناث .
- الاصابة بالشفة الارنبية في الجهة اليسري اكثر حدوثا من الجهة اليمنى . (الصبي و اخرون , ٢٠١٩).

انواع او اشكال الشفة الارنبية :

هناك انواع او اشكال متعددة من الاصابة بالشفة الارنبية و هي :

- الشفة الارنبية (شق الشفة) :

- الشفة الارنبية الغير مكتملة - الجزئية :احادية الجانب الجزئية .
- الشفة الارنبية المكتملة :احادية الجانب الكاملة .
- الشفة الارنبية ثنائية الجانب .

- الشفة الارنبية و شق سقف الحلق :

- الشفة الارنبية و شق سقف الحلق احادية الجانب .
- الشفة الارنبية و شق سقف الحلق ثنائية الجانب .

- شق سقف الحلق :

- شق سقف الحلق تحت الغشائي (الغير ظاهر) .
- شق سقف الحلق غير المكتمل .
- شق سقف الحلق الثانوي و لسان المزمار .
- شق لسان المزمار .
- شق سقف الحلق الجزئي احادي الجانب .
- شق سقف الحلق الكامل احادي الجانب
- شق سقف الحلق الكامل ثنائي الجانب . (الصبي و اخرون , ٢٠١٩).

المشاكل و المضاعفات المصاحبة للشفة الارنبية و شق سقف الحلق :

(١) المشاكل التي تواجه اثناء تناول الطعام (مشاكل التغذية) .

(٢) سوء الشكل الخارجي للوجة .

(٣) عدم انتظام نمو عظام الفك العلوي و الوجة .

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

٤) مشاكل اثناء نمو الاسنان .

٥) مشاكل التهابات الاذن و مشاكل في السمع .

٦) عيوب مخارج النطق و الكلام و الالفاظ .

٧) المشاكل النفسية التي تواجه المصاب .(الصبي و اخرون ,٢٠١٩).

خصائص الكلام و النطق عند الاطفال المصابين بالشفة الارنبية و هي :

١. **اضطرابات النطق :** وهي الاخطاء في مخارج الحروف و اصواتها من حيث مواقعها الطبيعية و

قد تكون الاخطاء النطقية المرتبطة بالشفة الارنبية اما اخطاء ابدالية و هي ابدال حرف مكان

حرف اخر مثل استبدال حرف (س) بحرف (ش) .

٢. **الخنف :** او ما يسمى باضطرابات الرنين الانفي و هو تغير خصائص الصوت اثناء خروجه

من التجويف الانفي اثناء الكلام .

٣. **الاضطرابات الصوتية :** مثل بحة الصوت , الصوت المنخفض , النبرة المتغيرة و الغير طبيعية

للصوت .

٤. **عدم وضوح الكلام بشكل طبيعي او واضح .**(الصبي و اخرون ,٢٠١٩).

الاجراءات العلاجية الازمة في حالة وجود طفل مصاب بالشفة الارنبية و هي :

١) **طبيب او جراح التجميل :** و هو يقوم باغلاق الشفة الارنبية و شق سقف الحلق عن طريق

الجراحة .

٢) **طبيب تقويم الاسنان و الفكين :** و هو يقوم بالمحافظة علي الشكل السليم للفك و الاسنان و

هو تدخل جراحي قبل ظهور الاسنان و يقوم بمتابعة حالة اسنان الطفل المصاب من حيث

الشكل و البنية و مواقع بزوغها و زيادة عددها او نقصانها .

٣) **اخصائي النطق و التخاطب :** و هو يقوم بتقييم قدرات الطفل اللغوية و النطق و الكلام و يقوم

بعلاج عيوب النطق المصاحبة تبع حالة الطفل .

٤) **اخصائي التغذية :** و هو يتابع قدرة البلع عند الطفل و يساعد في تقديم طرق التغذية المناسبة

حسب حالة الطفل .

٥) **طبيب الاطفال :** و هو يقوم بمتابعة حالة الطفل و معالجة اي تدهورات تحدث في حالة الطفل.

٦) **طبيب الانف و الاذن و الحنجرة :** لمتابعة حالة الاذن و علاج الالتهابات المصاحبة و علاج

لقناة استاكيوس (القناة التي تربط بين الانف و الاذن).

٧) **الاخصائي النفسي :** حيث يقدم المساعدة للوالدين بعد الولادة مباشرة و يستمر في تقييم حالة

الطفل النفسية في جميع المراحل الخاصة بالطفل .(الصبي و اخرون , ٢٠١٩).

الاجراءات الجراحية اللازمة في حالة وجود الاصابة بالشفة الارنبية :

- (١) شق الشفة الارنبية : عند الثلاثة اشهر الاولى من عمر الطفل .
 - (٢) شق سقف الحلق : تتم من ٦-١٢ شهر .
 - (٣) سد فتحة شق سقف الحنك في الفك العلوي : تتم من ١١ - ١٢ سنة من عمر الطفل .
 - (٤) متابعة لتصحيح مخارج الحروف .
 - (٥) المعالجات الفكية : تتم من ٦ - ١٤ سنة من عمر الطفل .
 - (٦) عملية تصحيح الفكين عند الطفل المصاب .
 - (٧) عمليات تجميل الانف و الشفة عند الطفل : تتم من ١٦-١٨ سنة بعد ان تتم عمليات جراحة الفكين و تعديلهم ان لزم الامر . (الصبي و اخرون ، ٢٠١٩).
- امور علي الاهل و الوالدين يجب مراعاتها في الطفل المصاب بالشفة الارنبية و هي :
- (١) التأكد من سلامة السمع و مراقبة استجابة الطفل للسمع و متابعة التهابات الاذن عن طريق طبيب الاذن .
 - (٢) القيام بفحص سمع الطفل مرتان في العام علي الاقل .
 - (٣) متابعة نمو الاصوات لدي الطفل بشكل طبيعي ام لا .
 - (٤) متابعة نمو اللغة عند الطفل .
 - (٥) مساندة الطفل في نمو الثقة بالنفس لدي الطفل المصاب و المساواة في التعامل بينه و بين اخواته .
 - (٦) الرجوع لاختصاصي النطق و التخاطب في حالة وجود مؤشرات علي اضطرابات النطق و الكلام (الصبي و اخرون ، ٢٠١٩).
- تعقيب الباحثة علي محور الشفة الارنبية :**
- يتضح من خلال عرض الاطار النظري و اطلاع الباحثة علي الكتب و الدراسات السابقة و البحوث و المجالات التي تكلمت عن الشفة الارنبية تري انها في تزايد من الاعداد المصابه من الاطفال مما جعلها تعرض اهميتها في الدراسة الخاصة بها للبحث عن حلول لها او طرق للتعامل معها .
- تعقيب الباحثة علي الاطار النظري كله :
- من خلال عرض كل ما سبق واطلاع الباحثة علي الدراسات الخاصة بكل محور جعل اضطراب فرط النشاط الحركي و اضطراب اللغة و الشفة الارنبية محور اهتمام الباحثة في رسالتها و مدي اهميتها في تأثيرهما علي الطفل و حياته و طرق تعامله .
- اهم الدراسات و البحوث السابقة :**

هدفت دراسة (منيرة عبد الرحمن منصور ، لسنة ٢٠١٥)، الي التعرف علي فعالية البرنامج التدريبي في خفض سلوك النشاط الزائد و تشتت الانتباه لدي الاطفال المعاقين ذهنيا بدرجة بسيطة في الكويت ، تكونت عينة الدراسة من ١٢ طالب تتراوح اعمارهم من (٧-١٠) سنوات تم توزيعهم عشوائيا ، و استخدمت الدراسة

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

المنهج التجريبي، وأسفرت نتائج الدراسة الي :توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في اضطراب النشاط الزائد و تشتت الانتباه لدي التلاميذ. كما هدفت دراسة(فوزية محمدي ،لسنة ٢٠١١)،الي تصميم برنامج تدريبي يساعد علي تعديل سلوك النشاط الزائد المصحوب بتشتت الانتباه و برنامج تدريبي يساعد علي تعديل صعوبات بالكتابة ، تكونت عينة الدراسة من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي ذكور و اناث و عمرهم ٩ سنوات،و اعتمدت علي المنهج التجريبي في الدراسة،و اسفرت نتائج الدراسة الي : فعالية برنامجيين تدريبيين في تعديل سلوك اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت الانتباه و تعديل صعوبة الكتابة. وهدفت دراسة(صالح بن يحيي الجار اللة الغامدي ،لسنة ٢٠٠٩) الي التعرف علي درجة انتشار اضطرابات الكلام و اكثرها شيوعا بين الاطفال وعلاقتها بالثقة بالنفس و تقدير الذات لدي عينة من طلاب المرحلة المتوسطة،واستخدمة الدراسة المنهج الوصفي (الارتباطي و المقارن) و اسفرت نتائج الدراسة الي :درجه انتشار اضطرابات مرتفعة بين الاطفال .كما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين اضطرابات الكلام و الثقة بالنفس لدي المضطربين في الكلام.

وفي دراسة فولكير وآخرون (Volker, et al, 2014). ألمانيا "Children with a cleft lip and

palate: An exploratory study of the role of the parent-child interaction"

الأطفال الذين يعانون من شق الشفة وقبة الحنك :د راسة استكشافية لدور التفاعل بين الوالدين والطفل" هدفت إلى معرفة نوعية العلاقات الأسرية بين الوالدين والأطفال المصابين بشق الشفة وقبة الحنك من خلال : (التعلق، الحماية الزائدة) وأثرها على الطفل من الناحية النفسية. عينة الدراسة: بلغت العينة (٢٠) أسرة ممن لديهم أطفال مصابين بشق الشفة وقبة الحنك الذين يرتادون (المشفى الطبي في فرانكفورت الخاص بجراحة الفكين والأسنان، وكان متوسط أعمار الأطفال ١٢.٥ سنة و اتبع المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة و أظهرت النتائج تقارب في النسب المئوية على محوري التعلق والحماية الزائدة، والأثر السلبي على الأطفال من الناحية النفسية، حيث أظهرت نتائج الاستبيان الموجه للأطفال بأنهم أقل ثقة بأنفسهم، وزيادة في درجة التعلق، وكذلك كانت نسبة الخجل لديهم مرتفعة، بينما كانت نسبة القلق لديهم متوسطة، ولم تظهر فروقاً في متوسطات إجابات الأطفال على المقياس.

اشارت دراسة (جيسون GIBSON (٢٠٠٣)) حول فعالية برنامج لغوي قائم علي تنمية الاصوات اللغوية للأطفال ذوي الاضطرابات الصوتية و النطقية بهدف تطوير برنامج لغوي قائم علي تنمية الاصوات اللغوية للأطفال ذوي الاضطرابات الصوتية و النطقية قائم علي اسلوب النمذجة و محاكاة اللغة المنطوقة من قبل الكبار و مقارنتهم مع الاطفال العاديين و تم تطبيقه علي عينة بلغ عددهم (٣٠) طفل و طفلة و اسخدمة الباحث المنهج التجريبي في الدراسة.

فروض الدراسة

من خلال الاستفادة من الإطار النظري والدراسات السابقة المذكورة أعلاه، وكذلك الأدبيات التي تناولت متغيرات البحث، يمكن تحديد وصياغة الفروض التي يسعى البحث الحالي إلي التحقق من مدى صحتها بالقبول أو الرفض، في الفروض التالية:

١. توجد فروق ذات دلالة احصائية في اضطرابات اللغة لدى عينة الدراسة.
٢. توجد فروق ذات دلالة احصائية في فرط النشاط الحركي لدى عينة الدراسة.
٣. توجد علاقة دالة إحصائية بين فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية.
٤. توجد علاقة دالة إحصائية بين فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية.
٥. لا توجد فروق في فرط النشاط الحركي تعزى لمتغير النوع لدى الأطفال الشفة الأرنبية.
٦. لا توجد فروق في بعض اضطرابات اللغة تعزى لمتغير النوع لدى الأطفال الشفة الأرنبية.

منهج الدراسة:

أولاً: التصميم المنهجي :

اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي الإرباطي المقارن وذلك للتحقق من الهدف الرئيسي للدراسة وهو تحديد العلاقة بين فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة (الحذف و الإبدال) لدى عينة من اطفال الشفة الارنبية ، في متغيرات الدراسة.

ثانياً: عينة الدراسة:

أ- عينة حساب الخصائص السيكومترية للأدوات: تكونت عينة حساب الخصائص السيكومترية للأدوات من (٣٠) من طفل و طفلة لمرحلة ما قبل المدرسة و ذلك في مستشفى جامعه المنيا عيادة الشفة الارنبية و بعض مراكز التربية الخاصة بمدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا بهدف حساب الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة الحالية.

ب - العينة الأساسية: تكونت عينة الدراسة الأساسية من (٣٥) طفل و طفلة من مرحلة اطفال ما قبل المدرسة و تواجدت هذه العينة في مستشفى جامعه المنيا عيادة الشفة الارنبية و بعض مراكز التربية الخاصة بمدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا وقد تراوحت أعمارهم ما بين (٣ - ٦) عاماً. والجدول (١) يوضح توزيع عينة الدراسة على الاماكن (المستشفيات و المراكز) التي تم التطبيق بها.

جدول (١) عينة الدراسة بالمستشفيات و المراكز

م	اسم المكان التي تم التطبيق فيه	عدد الاطفال		الإجمالي
		طفلة	طفل	
١	مستشفى جامعة المنيا عيادة الشفة الارنبية	١٨	١٢	٣٠
٢	مركز كيان بمدينة ملوي	٢	٣	٥

المجموع	٢٠	١٥	٣٥
---------	----	----	----

ثالثا . أدوات الدراسة:

(١) مقياس فرط النشاط الحركي عند الاطفال اعداد(جمال الخطيب): قامت الباحثة باستخدام مقياس فرط النشاط الحركي اعداد جمال الخطيب من خلال الخطوات التالية.

أ. الإطلاع علي المقياس الخاص بفرط النشاط الحركي للاطفال اعداد جمال الخطيب بصفة عامة.
ب. الإطلاع على محاور المقياس حيث تكون من ثلاث محاور فرعية و هما :

(١) محور اعراض ضعف الانتباه لدي الاطفال

(٢) محور اعراض فرط الحركة لدي الاطفال

(٣) محور اعراض الاندفاعية لدي الاطفال

ووجدت ايضا الباحثة بان المقياس يتم تقيمه من خلال جهاتين و هما:

الجهة الاولى :من خلال المعلم الخاص بالطفل او الطبيب الخاص بالطفل.

الجهة الثانية :من خلال الاباء او الاسره الخاصة بالطفل.

ووجدت الباحثة لكلا منهم بنود خاصة بهم يتم تحديد درجاتها القائم بالتشخيص (نادرا قليلا،غالبا،دائما). وبعد اطلاع الباحثة علي مقياس فرط النشاط الحركي لدي الاطفال اعداد جمال الخطيب وجدت ان ما يتلائم مع طبيعته فروض البحث الخاص بها هو المحور الثاني الا و هو محور اعراض فرط الحركة لدي الاطفال و لذلك تم انتقاء هذا الجزء من ذلك المقياس ليتم تطبيقه علي الاطفال من خلال الطبيب الخاص بالطفل و من خلال اسرة الطفل .

الخصائص السيكومترية لمقياس فرط الحركة لدي اطفال الشقة الارنبية :

استبيان تشخيص حالات فرط الحركة و تشتت الانتباه لدى الاطفال اعداد (الخطيب): اسئلة هذا الاستبيان مبنية علي الطرق العلمية المستخدمة في المراجع و المراكز التخصصية الامريكية , و هي تعتمد علي وجود ثلاثة اعراض قياسية ليتم تشخيص ان الطفل مصاب بالاضطراب من عدمه, و يتم اعداد الاستبيان بالتعاون بين الوالدين من جهة و بين المدرسة بمساعدة الاستاذ المشرف علي الطفل , كما يجب الاشارة الي انه يتبقي لدي طبيب الاطفال او المختص النفسي اسئلة مهمة حتي يحاول التعرف علي الاسباب المحتملة و التي قد تكون هي التي ادت الي الاصابة باضطراب فرط النشاط الحركي.

الاعراض القياسية التي بموجبها تشخيص الطفل هي (اعراض ضعف الانتباه , اعراض فرط الحركة , اعراض الاندفاعية) ولكن الباحثة للدراسة الحالية استكتفت باعراض فرط الحركة فقط لمؤلامته مع طبيعة الدراسة او البحث الحالي.

وتنقسم اسئلة الاستبيان الي قسمين رئيسين و هما :

استبيان الاسرة: وهي اسئلة خاصة بالاسرة يشترك كلا من الاب و الام في الاجابة عليها مع الالتزام بالتركيز الشديد و عدم خلط سلوكيات و تصرفات الطفل و نسبها لعوامل تربوية.

استبيان المدرسة: يقوم المعلم او المعلمة المشرف علي الطفل بالاجابة علي اسئلة هذا الاستبيان مراعي الدقة و الموضوعية .و هذه الاسئلة تتحري سلوك و عقلية الطفل في المدرسة او مع اقارنة التلاميذ.

طريقة احتساب الاجابة بعد الانتهاء من اجابة اسئلة الاستبيان من قبل الاسرة و المدرسة يتم احتساب الدرجات بالطريقة التالية: نادرا = صفرا، قليلا = درجة واحدة ، غالبا = درجتان ، دائما = ثلاث درجات .

في استبيان المدرسة: اقل درجة يمكن الحصول عليها هي (صفر) درجة ، و اعلي درجة يمكن الحصول عليها هي (١٦٥) درجة.

في استبيان الاسرة: اقل درجة يمكن الحصول عليها هي (صفر) درجة، و اعلي درجة يمكن الحصول عليها هي (١٨٣) درجة.

مجموع الدرجات = مجموع الدرجة القصوى $165 + 183 = 348$ درجة.

متوسط مجموع الدرجات الكلي $248 / 2 = 124$ درجة .

فاذا حصل الطفل علي ١٤٧ درجة فاكتر فانه يعاني من اعراض فرط الحركة.

وقامت الباحثة الحالية بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على عينة مكونة من (٢٥) فرداً، وذلك على النحو التالي:

(أ) صورة المدرسة:

أولاً: الاتساق الداخلي:

وذلك من خلال درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية بإيجاد معامل ارتباط بيرسون

(Pearson) بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية والجدول (١) يوضح ذلك:

جدول (١) معاملات الارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس فرط الحركة (صورة

المدرسة)

رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط
١	٠,٨١٦	١٢	٠,٦٤٧	٢٣	٠,٨٧٦	٣٤	٠,٧٨٤	٤٥	٠,٥٥٧
٢	٠,٨٢٣	١٣	٠,٨١٠	٢٤	٠,٨٨٥	٣٥	٠,٧٦٢	٤٦	٠,٥٢١
٣	٠,٨٢٢	١٤	٠,٧٨١	٢٥	٠,٧٩٨	٣٦	٠,٨٤٨	٤٧	٠,٦٣٢
٤	٠,٧٧٣	١٥	٠,٧٧٥	٢٦	٠,٨٤٢	٣٧	٠,٧٣٣	٤٨	٠,٥٨٧
٥	٠,٦٢٥	١٦	٠,٦٢٥	٢٧	٠,٥٢١	٣٨	٠,٥٤٧	٤٩	٠,٥١٠
٦	٠,٥٤٤	١٧	٠,٥٧٤	٢٨	٠,٥٨٧	٣٩	٠,٥٣٢	٥٠	٠,٥٢٥
٧	٠,٥٥٤	١٨	٠,٥٩٨	٢٩	٠,٥٣٢	٤٠	٠,٥٩٨	٥١	٠,٧١٨
٨	٠,٦٠٥	١٩	٠,٥٢٨	٣٠	٠,٥٢١	٤١	٠,٥٤٧	٥٢	٠,٦٣٤
٩	٠,٥٤٨	٢٠	٠,٦٣٦	٣١	٠,٦٣٢	٤٢	٠,٥٣٢	٥٣	٠,٥٤٢
١٠	٠,٦٩٦	٢١	٠,٥٤٦	٣٢	٠,٦٤٥	٤٣	٠,٥٨٤	٥٤	٠,٥٥٧
١١	٠,٦٢٥	٢٢	٠,٦٢٢	٣٣	٠,٥٨٧	٤٤	٠,٤٨٧	٥٥	٠,٥٨٢

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (٨) أنَّ كل مفردات مقياس فرط الحركة (صورة المدرسة) معاملات ارتباطه موجبة

ودالة إحصائيًا عند مستوى (٠.٠١)، أى أنَّها تتمتع بالاتساق الداخلي.

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

ثانياً: الثبات:

تمّ ذلك بحساب ثبات مقياس فرط الحركة (صورة المدرسة) من خلال إعادة تطبيق المقياس بفواصل زمني قدره أسبوعين، وبطريقة ألفا - كرونباخ والتجزئة النصفية وذلك على عينة التحقق من الخصائص السيكمترية، وبيان ذلك في الجدول (٢):

جدول (٢) نتائج الثبات لمقياس فرط الحركة (صورة المدرسة)

إعادة التطبيق	معامل ألفا - كرونباخ	التجزئة النصفية
٠,٨١٩	٠,٨٠٤	سبيرمان - براون
		جتمان
		٠,٧٢٤

يتضح من خلال جدول (٢) أنّ معاملات الثبات مرتفعة، مما يعطى مؤشراً جيداً لثبات المقياس، وبناءً عليه يمكن العمل به.

(ب) صورة الأسرة:

أولاً: الاتساق الداخلي:

وذلك من خلال درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكمترية بإيجاد معامل ارتباط بيرسون (Pearson) بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية والجدول (٣) يوضح ذلك:

جدول (٣) معاملات الارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس فرط الحركة (صورة الأسرة)

رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط	رقم المفردة	معامل الارتباط
١	٠,٥٢٤	١٤	٠,٥٢٢	٢٧	٠,٤٨٧	٤٠	٠,٥٢٨	٥٣	٠,٦٢٥
٢	٠,٥٤٨	١٥	٠,٦٠٨	٢٨	٠,٦٢٥	٤١	٠,٦٢٩	٥٤	٠,٥٢١
٣	٠,٦٢٥	١٦	٠,٦٣٩	٢٩	٠,٤٩٥	٤٢	٠,٥٤١	٥٥	٠,٤٩٦
٤	٠,٤٢١	١٧	٠,٦٤٥	٣٠	٠,٦٣٥	٤٣	٠,٥٢٨	٥٦	٠,٥٢٨
٥	٠,٦٨٩	١٨	٠,٦٢٢	٣١	٠,٥٤٧	٤٤	٠,٣٢٥	٥٧	٠,٤٨٧
٦	٠,٦٢٥	١٩	٠,٥٠٨	٣٢	٠,٦١٥	٤٥	٠,٥٢٨	٥٨	٠,٦٣٢
٧	٠,٥٤٨	٢٠	٠,٦٤٥	٣٣	٠,٦٠٥	٤٦	٠,٦٢٥	٥٩	٠,٦٩٥
٨	٠,٥١٤	٢١	٠,٥٧١	٣٤	٠,٥٣٢	٤٧	٠,٤١٥	٦٠	٠,٥٤٠
٩	٠,٦٦٣	٢٢	٠,٥١٨	٣٥	٠,٥٩٨	٤٨	٠,٥٥٤	٦١	٠,٥٢١
١٠	٠,٥٧٨	٢٣	٠,٥٢٨	٣٦	٠,٥٢٤	٤٩	٠,٥٨٧		
١١	٠,٥٠٨	٢٤	٠,٦٣٢	٣٧	٠,٥٣٦	٥٠	٠,٧٠٤		
١٢	٠,٥٤٦	٢٥	٠,٥٤٩	٣٨	٠,٥٨٧	٥١	٠,٦٣٩		
١٣	٠,٦٣٢	٢٦	٠,٦٣٢	٣٩	٠,٦٣٢	٥٢	٠,٥٨٧		

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (٣) أنّ كل مفردات مقياس فرط الحركة (صورة الأسرة) معاملات ارتباطه موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١)، أى أنّها تتمتع بالاتساق الداخلي.

ثانياً: الثبات:

تمّ ذلك بحساب ثبات مقياس فرط الحركة (صورة الأسرة) من خلال إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمني قدره أسبوعين، وبطريقة ألفا - كرونباخ والتجزئة النصفية وذلك على عينة التحقق من الخصائص السيكمترية، وبيان ذلك في الجدول (٤):

جدول (٤) نتائج الثبات لمقياس فرط الحركة (صورة الأسرة)

إعادة التطبيق	معامل ألفا - كرونباخ	التجزئة النصفية	
		سبيرمان - براون	جتمان
٠,٨٢١	٠,٧٩٦	٠,٨٧٣	٠,٧١٩

يتضح من خلال جدول (٤) أنّ معاملات الثبات مرتفعة، مما يعطى مؤشراً جيداً لثبات المقياس، وبناءً عليه يمكن العمل به.

(٢) المقياس اللغوي العرب (إعداد: أحمد أبو حسيبة، ٢٠١١).

هدف المقياس: يستخدم هذا المقياس لتمييز وتشخيص الأطفال.

محتوى المقياس:

١- دليل الصور: وهذا الجزء يحتوي صوراً ملونة واضحة تستخدم في تطبيق الكثير من بنود الاختبار.

٢- سجل درجات الطفل: ويحتوي على تفاصيل كل بند ونسجل فيه الدرجات الخام التي يحصل عليها الطفل في جزئي الاختبار، كما يحتوي في نهايته على ملخص لما أجاب عليه الطفل مع توضيح للدرجات المعيارية للطفل وعمره اللغوي المقابل والبنود التي لم ينجح فيها، وهناك رسم توضيحي للعمر اللغوي للطفل ورسم توضيحي آخر لنقطة البدء ونقطة النهاية وأرقام البنود التي أخطأ فيها الطفل.

٣- أدوات ولعب بسيطة: وتستخدم للحصول على استجابة من الطفل ويجب أن تستخدم تحت إشراف الممتحن، وهذه الأدوات واللعب كالآتي: (كرة- مكعبات (خمس مكعبات)- صندوق بغطاء من البلاستيك- عربة صغيرة- شخيلة- ثلاثة معالق من البلاستيك- دبدوب صغير- ٣ أكواب بلاستيك- فوطة- مفاتيح خاصة بالممتحن).

ويتكون المقياس من عنصرين هما اختبار اللغة الاستقبالية (٦٢ بنداً)، اختبار اللغة التعبيرية (٧١ بنداً)، ويحتوي المقياس على جزأين ملحقين به وكل جزء يعطى معلومات منفصلة عن لغة الطفل ويشتمل المقياس على مجموعة من البنود هي (١٣٣) بند تقيس جانبين هما:

أ. جانب اللغة الاستقبالية (٦٢ بند): ويقاس مدى قدرة الطفل على الفهم وتنفيذ الأوامر البسيطة والمركبة وفهم الجمل والنفي والتضاد والصفات والظروف والمعارف العامة ومدى الانتباه والتمييز السمعي والبصري.

ب. جانب اللغة التعبيرية (٧١ بند): ويقاس مدى قدرة الطفل على التحدث بشكل جيد من حيث المفردات والجمل كاملة الأركان من حيث السياق والنمو والبلاغة واستخدام الضمائر والإشارة

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

والظرف والمبني للمجهول والمفرد والمثنى والجمع والمذكر والعطف والحال وكل ما يبين اللغة بشكل صحيح.

العمر الزمني الذي يشمل الاختبار: تم تقنيته على الأطفال من سن شهرين إلى سن سبع سنوات وخمسة أشهر.

زمن الاختبار: يختلف زمن الاختبار باختلاف المرحلة العمرية للطفل ومدى تعاونه مع الممتحن عند اختبار طفل من شهرين حتى عمر سنة يكون هناك وقت للعب مع الطفل لملاحظة بعض السلوكيات الخاصة بالطفل أثناء اللعب وتتراوح مدة الاختبار كما يلي:

١- من الولادة إلى ١١ شهر = ٢٠ - ٤٠ دقيقة.

٢- من ١٢ شهر إلى ٣ سنوات و ١١ شهر = ٣٠ - ٤٠ دقيقة.

٣- من ٤ سنوات إلى ٦ سنوات و ١١ شهر = ٢٥ - ٤٥ دقيقة.

تعليمات عامة للتطبيق:

١. على الممتحن قبل البدء في الاختبار أخذ التاريخ المرضي للطفل وأن يحصل على معلومات كافية عن النمو الحركي وحالة الطفل السمعية وحالة الإبصار قبل بدء جلسة الاختبار.
٢. حجرة الاختبار لا بد أن تتميز بالهدوء وأن تكون جيدة التهوية وجيدة الإنارة.
٣. من المسموح به أثناء جلسة الاختبار جلوس الطفل على رجل الأم أو جلوسه على الأرض وبالنسبة للأطفال في سن (٣) سنوات فما أكثر فإن جلوسهم أمام ترابيزة الفحص يكون أفضل.
٤. من الأفضل عدم تركيز النظر على الطفل في بداية دخول غرفة الاختبار ويستحسن أن يبدأ الممتحن مع الطفل بتقديم لعبة أو كتاب، وفي حالة تكرار الطفل لجملة "ما أعرفش" يجب على الممتحن أن يختار بند سهل يجيب عليه الطفل ويشجعه الممتحن.
٥. بالنسبة للأطفال الأقل من (٣) سنوات يجب تواجد أحد الأبوين مع الطفل، لكن لا ينبغي على الأبوين إعادة صياغة السؤال ولا يتدخل أحد الأبوين لمساعدة الطفل في الإجابة. وبالنسبة للأطفال في عمر (٣-٤) سنوات إذا حصل الممتحن على معلومات تؤكد استجابة الطفل وهو بمفرده لاختبارات مثل هذا الاختبار أو استجابته أثناء المقابلة التي تتم في بعض الحضانات عندئذ يمكن اختبار الطفل بدون تواجد الأب والأم، وبالنسبة للأطفال من (٥-٧) سنوات يمكن اختبار الطفل بدون تواجد الأبوين.
٦. يضع الممتحن لعب وأدوات معينة أمام الطفل تلك التي يحتاجها لاختبار بند معين مع وضع باقى اللعب بعيداً عن متناول الطفل، وبعد اختبار البند توضع اللعبة أو الأداة المستخدمة بعيداً عن الطفل لكي يقل تشتت الطفل ونزيد من تركيزه.
٧. لا يستطيع الطفل الجلوس لفترات طويلة لإتمام الاختبار لذا على الممتحن أن يمنح الطفل قسطاً من الراحة لتناول مشروب أو دخول الحمام.

٨. يوجد بدرجات سجل الطفل ملخصًا لدرجات الطفل والعمر المكافئ كما يوجد به تمثيل بياني للعمر المكافئ للطفل (العمر الاستقبالي والعمر التعبيري والعمر الكلي) وفي آخر سجل الدرجات يوجد (٣) خطوط بالعرض خط يمثل العمر الزمني للطفل وخط يمثل نقطة بدء الاختبار وخط آخر يمثل نقطة النهاية ويضع الممتحن دائرة على أرقام البنود التي لم يستطع الطفل الإجابة عليها.

نقطة البدء ونقطة النهاية في الاختبار: ينبغي على الفاحص قبل البدء في الاختبار أن تكون لديه معلومات عن قدرات الطفل اللغوية من خلال التاريخ المرضي ولقاء الوالدين والطفل، وبالنسبة للأطفال الأقل من ثلاث سنوات- لغويًا- يتم ملء الاستبيان الخاص بالوالدين، الممتحن يطرح أسئلة الاستبيان على الوالدين، أو يقوم الوالدين بملء الاستبيان بأنفسهم، وهناك جداول تبين نقطة البدء لكل مجموعة عمرية في نهاية الدليل.

المستوى القاعدي للغة الطفل: يتحدد بحصوله على درجة (١) في ثلاثة بنود متتالية، والطفل إذا لم يجتاز البنود الثلاثة من نقطة البدء تنتقل إلى السابقة لهذه البنود (عمر أقل) حتى يحصل الطفل على درجة واحدة في ثلاثة بنود متتالية، ومستوى السقف يتحدد بحصوله على (صفر) في خمسة بنود متتالية وتعتبر كل البنود التي تسبق المستوى القاعدي بنود صحيحة إذا حصل الطفل فيها على درجة واحد.

* تعتبر إجابة الطفل صحيحة لو أن الممتحن لاحظ أى نوع من أنواع الاستجابات الثلاثة التالية دون أن يؤثر ذلك على حساب الدرجة (لو الإجابة الصحيحة كانت تلقائية يحصل على درجة واحدة وكذلك لو كانت مستحثة أو عن طريق الوالدين).

١. إجابة تلقائية من الطفل ويرمز لها بالرمز (I) أى تلقائية بمعنى أن الممتحن لاحظ الطفل يفعل السلوك المراد اختباره تلقائيًا مع الأبوين أو الممتحن في أى وقت أثناء جلسة الاختبار.

٢. إجابة مستحثة ويرمز لها بالرمز (II) الممتحن يستحث الطفل لعمل سلوك معين من خلال الوسائل المبينة مع كل بند.

٣. إجابة عن طريق تأكيد الوالدين على حدوثها ويرمز لها بالرمز (III) الوالدان يؤكدان على حدوث السلوك المراد اختباره في المنزل.

٤. لو أن الطفل حقق شرط اجتياز البند أسفل فليس من الضروري عرض باقي أجزاء البند على الطفل إلا إذا أراد الممتحن أن يعرف معلومات أكثر عن لغة الطفل.

طريقة حساب الدرجات:

استجابة الطفل للاختبار يعبر عنها باستخدام الدرجات الخام- الدرجة المعيارية- العمر المكافئ- نقطة الحد الفاصل.

الدرجات الخام:

١- لحساب الدرجات الخام لكل من جزئى الاختبار (اختبار اللغة الاستقبالي- اختبار اللغة التعبيري)

يتم طرح عدد البنود التي حصل فيها الطفل على درجة (صفر) من رقم آخر بند توقف الطفل عنده بالنسبة

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

لكل جزء والفارق يكون هو الدرجة الخام لكل جزء مثال آخر بند في الجزء الاستقبالي آخر بند توقف الطفل عنده بعد خمس أخطاء متتالية أى أن الدرجات الخام تساوي عدد البنود التي أجاب عنها الطفل بشكل صحيح.

٢- يعتبر الطفل أجاب البنود السابقة لنقطة البداية إجابة صحيحة وكل بند يحصل فيها الطفل على

درجة (١).

الدرجة المعيارية:

توجد جداول في نهاية دليل الاختبار يمكن من خلالها تحويل الدرجات الخام إلى درجة معيارية (الدرجة المعيارية بمتوسط ١٠٠ وانحراف معياري ١٥) بالنسبة لأي مجموعة عمرية. ولتقييم لغة الطفل بأنها مناسبة لسنه يجب أن تكون درجته المعيارية الكلية (للجزء الاستقبالي و التعبيري للمقياس) في حدود (٥,١) انحراف معياري بالنسبة للمتوسط ١٠٠ (فالطفل الطبيعي يحصل على درجة معيارية من (٥,٧٧ - ٥,١٢٢) بالنسبة لأي مجموعة عمرية، وبالتالي يتم تشخيص الطفل على أنه متأخر لغوياً إذا حصل على درجة معيارية أقل من (٥,٧٧) درجة معيارية.

العمر المكافئ: يوجد جداول في نهاية الدليل لتحويل الدرجة الخام للعمر المكافئ بالنسبة لجزئي الاختبار وبالنسبة للدرجة الكلية.

نقطة الحد الفاصل: يوجد في نهاية الدليل جدول يبين نقطة الحد الفاصل بالنسبة للدرجات الخام في الجزء الاستقبالي والتعبيري والمجموع الكلي كوسيلة مباشرة سهلة لتقييم الطفل.

تقنين المقياس اللغوي للأطفال.

تم تقنين المقياس على (٣٤٠) طفل من الأطفال الأسوياء لغوياً وعقلياً وجسمانياً. وشملت العينة أطفالاً من صعيد مصر (المنيا) والوجه البحري (القاهرة) كما شملت العينة مختلف الأنماط الاجتماعية وكانت هناك نسب متقاربة من الأولاد والبنات الذين شملتهم العينة.

تم عمل الاختبار على عينة استطلاعية تتألف من (١٧٠) طفل لتحديد مدى ملائمة البنود كما أمكن من خلال تلك العينة تعديل ترتيب بعض البنود حذف بنود وإضافة بنود. ولتحقيق ثبات المقياس تم اختبار (٩٠) طفلاً من الأطفال ذوي التأخر اللغوي ومقارنتهم بمجموعة مقابلة من الأطفال الأسوياء.

صدق المقياس:

- صحة التغيرات مع نمو الطفل أثبت المقياس أن متوسط درجات الطفل تزداد بازدياد عمر الطفل.

- صحة المقياس باستخدام طريقة التناسق الداخلي تتراوح معامل التناسق الداخلي من (٠.٩٩٨-٠.٩٩١) وهذا يدل على مدى صحة المقياس.

- إثبات الصحة باستخدام المقارنة بين المجموعات المتباينة ومن خلال كل هذه الإثباتات يتبين مدى موثوقية وصحة المقياس اللغوي المعرب كوسيلة موضوعية لتقييم لغة الطفل العربي.

ثبات المقياس:

١- طريقة إعادة الاختبار: حيث كانت المسافة الزمنية بين الاختبار وإعادته من يومين إلى أربعة عشر يوماً وبعد تقييم العلاقة بين الاختبار وإعادة الاختبار كانت النتائج تتراوح (٠.٩٨ - ٠.٥٤) وهذا يدل على مدى موثوقية المقياس المعرب.

٢- الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: حيث تتراوح نتائجها من (٠.٩٢ - ٠.٦٠) مما يدل على موثوقية المقياس المعرب.

وقامت الباحثة الحالية بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على عينة مكونة من (٢٥) فرداً، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الاتساق الداخلي:

١- اتساق المفردات مع الدرجة الكلية للمقياس:

وذلك من خلال درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية بإيجاد معامل ارتباط بيرسون (Pearson) بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس والجدول (٥) يوضح ذلك:

جدول (٥) معاملات الارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لأبعاد المقياس اللغوي المعرب

اللغة التعبيرية				اللغة الاستقبالية			
معامل الارتباط	المفردة	معامل الارتباط	المفردة	معامل الارتباط	المفردة	معامل الارتباط	المفردة
**٠,٦٢٥	٣٧	**٠,٢٤٠	١	**٠,٥٤٥	٣٧	**٠,٥١٤	١
**٠,٨٣٨	٣٨	**٠,٢٨٩	٢	**٠,٥٠١	٣٨	**٠,٤١٤	٢
**٠,٤٧٦	٣٩	**٠,٣٥٣	٣	*٠,٢٦٥	٣٩	**٠,٦٢٥	٣
**٠,٥١٣	٤٠	**٠,٣١٢	٤	**٠,٤٣٢	٤٠	**٠,٤١٤	٤
**٠,٦٠٦	٤١	**٠,٣١٢	٥	**٠,٦٥٤	٤١	**٠,٦٤٧	٥
**٠,٦٤٥	٤٢	**٠,٢٨٨	٦	**٠,٤٢١	٤٢	**٠,٦٩٩	٦
**٠,٥٥١	٤٣	**٠,٢٩٨	٧	**٠,٦٠٥	٤٣	**٠,٥٥٥	٧
**٠,٥٧٦	٤٤	**٠,٣٢٣	٨	*٠,٢٦٢	٤٤	**٠,٥٢٦	٨
**٠,٦٠٨	٤٥	**٠,٢٣٩	٩	**٠,٦٢٤	٤٥	**٠,٦٠١	٩
**٠,٥٤٢	٤٦	*٠,٢٨١	١٠	**٠,٥٧٧	٤٦	**٠,٦٠٠	١٠
**٠,٦٣٢	٤٧	**٠,٥٨٥	١١	**٠,٦٢٥	٤٧	**٠,٦٢٥	١١
**٠,٤٨٧	٤٨	**٠,٦٣٢	١٢	**٠,٥٥١	٤٨	**٠,٥١٤	١٢
**٠,٦٣٩	٤٩	**٠,٥٨٤	١٣	**٠,٦٣٢	٤٩	**٠,٥٨٧	١٣
**٠,٧٥٤	٥٠	**٠,٥٤٦	١٤	**٠,٥٤١	٥٠	**٠,٤٦٥	١٤
**٠,٧٤١	٥١	**٠,٥٨٧	١٥	**٠,٤٩٨	٥١	**٠,٦٢٨	١٥
**٠,٥٨٤	٥٢	**٠,٥٢٨	١٦	**٠,٦٣٥	٥٢	**٠,٦٢١	١٦
**٠,٦٣٢	٥٣	**٠,٥١٤	١٧	**٠,٥٠٨	٥٣	**٠,٦٥٦	١٧
**٠,٥٧٩	٥٤	**٠,٦٣٢	١٨	**٠,٦٢٥	٥٤	**٠,٤٨٧	١٨
**٠,٥٧٨	٥٥	**٠,٥٨٧	١٩	**٠,٦٠٠	٥٥	**٠,٥٢١	١٩
**٠,٥٦٢	٥٦	**٠,٥٢١	٢٠	**٠,٦١١	٥٦	**٠,٥٨١	٢٠

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

**٠,٥٩٨	٥٧	**٠,٦٣٢	٢١	**٠,٥٤٨	٥٧	**٠,٥٦٤	٢١
**٠,٧٦٥	٥٨	**٠,٥٧٨	٢٢	**٠,٥٣٢	٥٨	**٠,٥٢٨	٢٢
**٠,٦٣٢	٥٩	**٠,٦٣٩	٢٣	**٠,٤٨٧	٥٩	**٠,٦٠٥	٢٣
**٠,٥٨٧	٦٠	**٠,٥١٧	٢٤	**٠,٦٣٢	٦٠	**٠,٥٤٨	٢٤
**٠,٦٥٢	٦١	**٠,٥٣١	٢٥	**٠,٥٨٧	٦١	**٠,٥٧٤	٢٥
**٠,٥٨٧	٦٢	**٠,٥٩٧	٢٦	**٠,٦٥٢	٦٢	**٠,٥٦٢	٢٦
**٠,٥٣٢	٦٣	**٠,٥٤٧	٢٧			**٠,٦٢٤	٢٧
**٠,٥٧٤	٦٤	**٠,٦٣٢	٢٨			**٠,٥٨٧	٢٨
**٠,٤٨٧	٦٥	**٠,٥٧٤	٢٩			**٠,٥٢٨	٢٩
**٠,٦٣٥	٦٦	**٠,٥٥٣	٣٠			**٠,٤٨٧	٣٠
**٠,٥٧٤	٦٧	**٠,٥٤٧	٣١			**٠,٦٣٢	٣١
**٠,٥٩٨	٦٨	**٠,٦٦٣	٣٢			**٠,٥٤١	٣٢
**٠,٦٣٢	٦٩	**٠,٥١٧	٣٣			**٠,٥٥٨	٣٣
**٠,٥٨٧	٧٠	**٠,٥٩٨	٣٤			**٠,٦٢٥	٣٤
**٠,٥١٤	٧١	**٠,٥٧٤	٣٥			**٠,٤٩٨	٣٥
		**٠,٦٣٢	٣٦			**٠,٦٣٢	٣٦

** دالة عند ٠.٠١ * دالة عند ٠.٠٥

يتضح من الجدول (٥) أنَّ كل مفردات المقياس اللغوي المعرب معاملات ارتباطها موجبة ودالة إحصائيًا عند مستويين (٠.٠١، ٠.٠٥)، أى أنَّها تتمتع بالاتساق الداخلي.

٢- الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس المساندة الأسرية:

تم حساب معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس اللغوي المعرب، وذلك من خلال حساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد، والدرجة الكلية للمقياس. ويوضح جدول (٦) معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس، والدلالة الإحصائية:

جدول (٦) معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس اللغوي المعرب، والدلالة الإحصائية

الأبعاد	الأول	الثاني	الكلية
اللغة الاستقبالية	-		
اللغة التعبيرية	**٠,٧١٤	-	
الدرجة الكلية	**٠,٦٩٥	**٠,٥٧٢	-

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

أوضحت النتائج في جدول (٦) أنَّ معاملات الارتباط لأبعاد المقياس اللغوي المعرب من خلال المصفوفة الارتباطية، كلها قيم مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (٠.٠١).

ثانياً: الثبات:

١- طريقة إعادة التطبيق:

وتَمَّ ذلك بحساب ثبات المقياس اللغوي المعرب من خلال إعادة التطبيق بفواصل زمني قدره أسبوعين وذلك على عينة الخصائص السيكومترية، وتم استخراج معاملات الارتباط بين درجات العينة باستخدام معامل بيرسون (Pearson)، وكانت جميع معاملات الارتباط دالة عند (٠.٠١) مما يشير إلى أنَّ المقياس يعطي نفس النتائج تقريباً إذا ما استخدم أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة وبيان ذلك في الجدول (٧):

جدول (٧) نتائج ثبات المقياس اللغوي المعرب بطريقة إعادة التطبيق

الأبعاد	معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني	مستوى الدلالة
اللغة الاستقبالية	٠,٨٢١	٠,٠١
اللغة التعبيرية	٠,٨٨٤	٠,٠١
الدرجة الكلية	٠,٨٦٥	٠,٠١

يتضح من خلال جدول (٧) وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني لأبعاد المقياس اللغوي المعرب، مما يدل على ثبات المقياس، ويؤكد ذلك صلاحية المقياس لقياس السمة التي وُضع من أجلها.

٢- طريقة معامل ألفا لكرونباخ:

تم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة الفا لكرونباخ. ويبين جدول (٨) قيم ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ:

جدول (٨) قيم ثبات المقياس اللغوي المعرب باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ

الأبعاد	ألفا لكرونباخ
اللغة الاستقبالية	٠,٧٠١
اللغة التعبيرية	٠,٧٢٥
الدرجة الكلية	٠,٧٦٢

يتضح من خلال جدول (٨) أنَّ معاملات الثبات مرتفعة، مما يعطي مؤشرًا جيدًا لثبات المقياس، وبناء عليه يمكن العمل به.

٣- طريقة التجزئة النصفية:

تم حساب ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية باستخدام كل من معادلة سبيرمان - براون وجتمان. ويبين جدول (٩) معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس اللغوي المعرب:

جدول (٩) معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس اللغوي المعرب

الأبعاد	سبيرمان بران	جيتمان
اللغة الاستقبالية	٠,٧٩٨	٠,٦٢٥
اللغة التعبيرية	٠,٨٠٥	٠,٧١١
الدرجة الكلية	٠,٨٢١	٠,٦٩٢

يتضح من جدول (٩) أنَّ معاملات ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان - براون متقاربة مع مثلتها طريقة جتمان، مما يدل على أنَّ المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

رابعاً: الخطوات الإجرائية:

تضمنت الخطوات الإجرائية التي قامت بها الباحثة في الدراسة على ما يلي:

(١) القيام بزيارات ميدانية لبيئات تعليمية و طبية(مراكز التربية الخاصة، المستشفيات الخاصة باطفال

الشفة الارنبية)، وذلك للتعرف على أعدادهم ومدى توفر شروط العينة فيهم.

(٢) حساب صدق وثبات أدوات الدراسة.

(٣) تحديد عينة الدراسة الأساسية.

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

- ٤) تطبيق مقاييس فرط الحركة و اضطرابات اللغة، على العينة الأساسية للدراسة.
- ٥) تصحيح الاستجابات وجدولة الدرجات ومعالجتها إحصائياً واستخلاص النتائج.
- ٦) مناقشة نتائج الدراسة ووضع التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.

الأساليب الإحصائية:

لحساب صدق وثبات مقاييس الدراسة والتحقق من فروض الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل الارتباط لبيرسون (Pearson)، التحليل العاملي، اختبار (ت) وتحليل التباين الأحادي وتحليل الانحدار، وذلك من خلال حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية والمعروفة اختصاراً بـ SPSS.

نتائج الدراسة:

التحقق من نتائج الفرض الأول:

ينص الفرض على أنه "توجد علاقة دالة إحصائية بين فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم معاملات ارتباط بيرسون (Pearson) بين كل من فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية، والجدول (١) يوضح ذلك:

جدول (١) قيم معاملات الارتباط بين فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية (ن = ٣٠)

اضطرابات اللغة (*)		فرط النشاط الحركي (*)	
		تقدير المعلم	تقدير الآباء
اللغة الاستقبلية		٠,٨٩٠ **	٠,٧٧٦ **
اللغة التعبيرية		٠,٨١١ **	٠,٨٣٩ **
الدرجة الكلية		٠,٨٧٥ **	٠,٨٣٣ **

** دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (١) وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين فرط النشاط الحركي وبعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية عند مستوى (٠.٠١)، وبذلك يكون الفرض الأول قد تحقق.

التحقق من نتائج الفرض الثاني:

(*) تم استخدام مقياس جمال الخطيب لفرط الحركة.
(*) تم استخدام مقياس اللغة لـ أحمد أبو حسيبة.

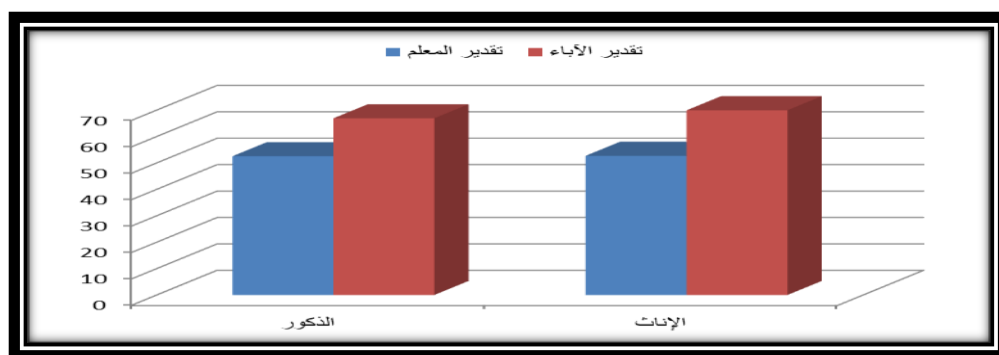
ينص الفرض على أنه "لا توجد فروق في فرط النشاط الحركي تعزى لمتغير النوع لدى الأطفال الشفة الأرنبية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار مان ويتي للمجموعتين المستقلتين، والجدول (٢) يوضح ذلك:

جدول (٢) الفروق في درجة فرط النشاط الحركي بين الذكور والإناث (ن = ٣٠)

الأبعاد	المجموعة	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة z	مستوى الدلالة
تقدير المعلم	الذكور	١٧	٥٢,٥٣	١,٨١	١٥,١٥	٢٥٧,٥٠	٠,٢٥٤	غير دالة
	الإناث	١٣	٥٢,٦٩	١,٩٣	١٥,٩٦	٢٠٧,٥٠		
تقدير الأباء	الذكور	١٧	٦٦,٨٨	١,٦٢	١٣,٣٨	٢٢٧,٥٠	١,٥٤٧	غير دالة
	الإناث	١٣	٦٩,٩٢	٥,٣٦	١٨,٢٧	٢٣٧,٥٠		

يتبين من جدول (٢) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات الذكور والإناث من الأطفال الشفة الأرنبية في فرط النشاط الحركي، وبذلك يكون الفرض الثاني قد تحقق.



والشكل البياني (١) يوضح ذلك:

شكل (١) الفروق في درجة فرط النشاط الحركي بين الذكور والإناث

التحقق من نتائج الفرض الثالث:

ينص الفرض على أنه "لا توجد فروق في بعض اضطرابات اللغة تعزى لمتغير النوع لدى الأطفال الشفة الأرنبية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار مان ويتي للمجموعتين المستقلتين، والجدول (٣) يوضح ذلك:

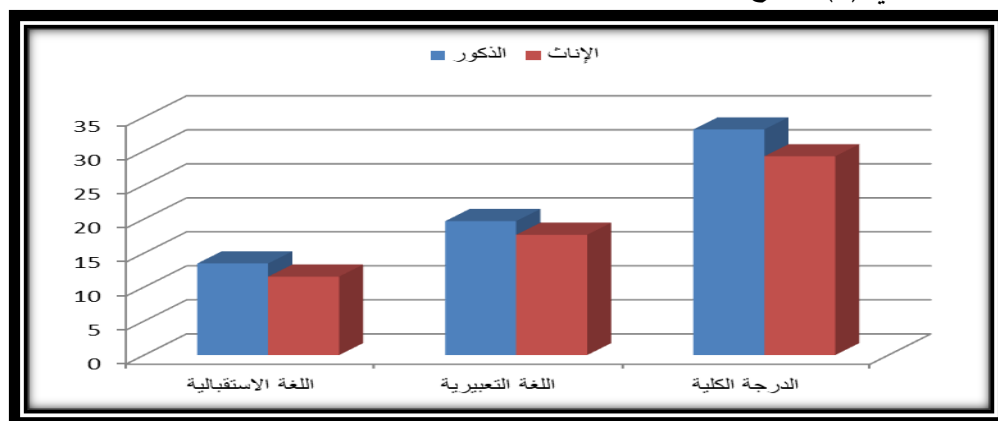
جدول (٣) الفروق في درجة بعض اضطرابات اللغة بين الذكور والإناث (ن = ٣٠)

الأبعاد	المجموعة	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة z	مستوى الدلالة
اللغة الاستقبالية	الذكور	١٧	١٣,٤٧	٣,٧٦	١٧,٦٢	٢٩٩,٥٠	١,٥١٣	غير دالة
	الإناث	١٣	١١,٥٤	٣,٠٢	١٢,٧٣	١٦٥,٥٠		
اللغة التعبيرية	الذكور	١٧	١٩,٧١	٦,١٧	١٧,٩١	٣٠٤,٥٠	١,٧٢١	غير دالة
	الإناث	١٣	١٧,٦٩	٤,٢٣	١٢,٣٥	١٦٠,٥٠		

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

الدرجة الكلية	الذكور	الإناث	غير دالة
	١٧	١٣	١,٨٤٧
٣٣,١٨	٢٩,٢٣	٦,٨٦	٩,٥٥
١٨,٠٩	١٢,١٢	١٥٧,٥٠	٣٠٧,٥٠

يتبين من جدول (٣) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات الذكور والإناث من الأطفال الشفة الأرنبية في بعض اضطرابات اللغة، وبذلك يكون الفرض الثالث قد تحقق. والشكل البياني (٢) يوضح ذلك:



شكل (٢) الفروق في درجة اضطرابات اللغة بين الذكور والإناث

مناقشة نتائج الدراسة:

بعد العرض السابق لنتائج الدراسة يمكن مناقشتها وتفسيرها في ضوء الفروض والدراسات السابقة والإطار النظري وذلك على النحو التالي:

أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية عكسية دالة وموجبة بين فرط النشاط الحركي و بعض اضطرابات اللغة عند مستوى دلالة (٠.٠٠١) كم تحقق بالفرض الأول، وأنه كلما زاد فرط النشاط الحركي قل وجود اللغة والعكس بالعكس، وكلما قل فرط النشاط الحركي زادت وجود اللغة. والمعني الادق ان كلما زاد فرط النشاط الحركي زاد وجود اضطرابات اللغة و كلما قل وجود فرط النشاط الحركي قل وجود اضطرابات اللغهدلى عينة الدراسة.

التعقيب على الفرض الثاني: اسفرت النتائج في الفرض الثاني بانه لا توجد فروق في فرط النشاط الحركي تعزي لمتغير النوع لدي اطفال الشفة الارنبية كما اوضحه اختبار مان ويتي الذي استخدمه للمجموعتين المستقلتين للتحقق من هذا الفرض , و بين انه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطي رتب درجات الذكور و الاناث من الاطفال الشفة الارنبية في فرط النشاط الحركي .

التعقيب على الفرض الثالث: اسفرت النتائج في الفرض الثالث بانه لا توجد فروق في بعض اضطرابات اللغة تعزي لمتغير النوع لدي الاطفال الشفة الارنبية وهذا ما اوضحه اختبار مان ويتي الذي استخدم للمجموعتين المستقلتين للتحقق من هذا الفرض , و بين انه لا توجد فروق في بعض اضطرابات اللغة تعزي لمتغير النوع لدي الاطفال الشفة الارنبية. وتتفق هذه النتائج مع دراسته كلا من (فوزيه محمدي ٢٠١١) ودراسه (ريم فهمي

(٢٠١٢) ودراسه جابن (Gapin, 2009) ودراسة نادري واخرين (Nadrie Heidarie, Bauran, & Asgari, 2010) ودراسة موراند (Morand, 2004) ودراسة باكماني واخرين (Packman, Jil, Bratton, 2003) ودراسة بريئر (Brenner, 2007) ودراسة ايدلمان (Edelman, 2011) ودراسة ايتمبرج واخرين (Sue, 2003) (Watemberg et. al, 2007) في انه توجد فروق ذات دلالة احصائية في مجال فرط الحركة لدى الاطفال. وايضا تتفق نتائج دراسة (نورة الغامدي, ٢٠٢١) ودراسة الدكتوروي و اخرون (Sciberras et al, 2014) (Al Dakroury and Gardner, 2017) ودراسة شيبيراز واخرون في انه يوجد علاقة ارتباطية موجبه بين فرط النشاط و اضطرابات اللغة عند الاطفال .

و تتفق هذه النتائج ايضا مع الاطر النظرية حيث ان كلا هؤلاء يؤكدون علي اهمية و شدة تاثير فرط النشاط الحركي علي الاطفال من حيث التصرفات و الافعال و ردود افعالهم و تاثيره علي اللغة الخاصة بالاطفال حيث ان فرط الحركة له تاثير قوي جدا علي اللغة اي ان كلما ارتفع فرط الحركة عند الطفل قلة اللغة و كلما قلة فرط الحركة زادت اللغة عند الطفل و هذا ما تما التاكيد منه اثناء تطبيق العملي للباحثة و خاصة لدي اطفال الشفة الارنبية اي ان اطفال الشفة الارنبية يولدون طبيعة و لديه بعضا من اضطرابات اللغة و لكن ثبت ايضا مع وجود فرط الحركة لدي الطفل يزداد اضطرابات اللغة لدي اطفال الشفة الارنبية و لذلك علي الوالدين متابعة اطفالهم ذوي الشفة الارنبية منذ ولدتهم و بعد اتمام العمليات الخاصة بالشفة الارنبية للتأكد من وجود فرط الحركة ام لا لدي الطفل و ايضا وجود اضطرابات اللغة لدي الطفل ام لا وفي حالة وجودهما عليهم الاهتمام الشديد بالطفل و متابعته عند الطبيب المختص لحالة الطفل حتي لا تتزايد المشكلات لدي الطفل و يتم معالجتها في وقتا باكر لان فرط الحركة لا يؤثر علي الطفل نفسة فقط ولكن يؤثر سلبا علي من حولة من الاشخاص مما يجعل الطفل مكروها لدي من حوله من الاشخاص و ايضا اللغة لها اهمية كبيرا جدا في تواصل الطفل مع من حولة و في حالة وجود اضطراب بها يجعل تواصل الطفل مع من حولة صعبا للغاية و لذلك علي الوالدين الاهتمام بطفلهم ذوي الشفة الارنبية منذ لحظة ولدته الي ان يتم عمليته الخاصة بالشفة الارنبية و ما بعدها .

وقد اختلفت نتائج كلا من (Byron, et al, 2009) دراسة الشخص (1991) , ودراسة زينب العطار (2001) ودراسة حسين (2010) مع نتائج الدراسة الحالية في انه نوع الجنس له تاثير في اضطرابات اللغة حيث يقولون ان الذكور اكثر عرضة من الاناث في الاصابة باضطرابات اللغة و كل هذا يختلف مع نتائج الدراسة الحالية إلا أنه دراسة السعيد (1999) تتفق مع الدراسة الحالية فيما يخص عدم وجود أثر ذو دلالة بالجنس (تساوي الذكور والإناث). اي ان الجنس لا يؤثر علي نسبة الاصابة باضطرابات اللغة و انهم يتساون مع بعضهم البعض ولا فرق بينهم.

ملخص النتائج: يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية في النقاط المحددة الآتية:

١) توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين فرط النشاط الحركي و بعض اضطرابات اللغة لدي عينة من اطفال الشفة الارنبية .

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

- (٢) لا توجد فروق في فرط النشاط الحركي تعزى لمتغير النوع لدى الأطفال الشفة الأرنبية.
- (٣) لا توجد فروق في بعض اضطرابات اللغة تعزى لمتغير النوع لدى الأطفال الشفة الأرنبية.

توصيات الدراسة:

- توصى الباحثة استنادًا إلى ما كشفت عنه الدراسة الحالية بما يلي:
- الاهتمام بنشر الوعي بفرط النشاط الحركي بشكل عام من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن خلال نشر الأسباب الملموسة حاليًا والتي قد تؤدي الى:
- (١) المشكلات التي تواجه الاطفال و الاباء و الناس عامة نظرا لأن فرط الحركة له تاثير كبير جدا علي الاطفال ذو فرط الحركة و علي الاباء و علي كل من حولة من البشر عامة.
 - (٢) قيام المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم لأسر اطفال ذو فرط النشاط الحركي، حتى يتمكنوا من رعايتهم، وتوفير الحقوق الأساسية لهم.
 - (٣) الاهتمام بتقديم الدعم الاجتماعي والمادى بكافة أشكاله لأفراد هذه الفئة.
 - (٤) عقد دورات تدريبية للاباء و للمعلمين لتوضيح خصائص هذه الفئة و مدي تاثيره في نموهم المتكامل وتحسين سلوكياتهم.
 - (٥) أن يكون هناك اتصال دائم بين المدرسة والمنزل من حيث التركيز على السلوكيات التي تصدر من الطفل داخل المنزل ومحاولة استبدالها بسلوكيات إيجابية من قبل المعلم داخل المدرسة.
 - (٦) الاهتمام بحث الطفل على المشاركة والتفاعل في المناقشات الجماعية، سواء داخل حجرة الدراسة أو خارجها.
 - (٧) الاهتمام بإظهار جوانب القوة لدى الاطفال، وتنميتها حتى تزداد ثقتهم بأنفسهم.
 - (٨) ايضا يجب الاهتمام بنشر الوعي باضطرابات اللغة بشكل عام من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن خلال نشر الأسباب الملموسة حاليًا والتي قد تؤدي الى المشكلات التي تواجه الاطفال اثناء تواصلهم مع الاخرين نظرا لأن اللغة لها اهمية كبيرة في التواصل .
 - (٩) قيام المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم لأسر الاطفال ذوي اضطرابات اللغة، حتى يتمكنوا من رعايتهم، وتوفير الحقوق الأساسية لهم.
 - (١٠) الاهتمام بتقديم الدعم الاجتماعي والمادى بكافة أشكاله لأفراد هذه الفئة.
 - (١١) عقد دورات تدريبية للاباء و المعلمين لتوضيح خصائص هذه الفئة وأهمية تاثير اضطراب اللغة في نموهم المتكامل وتحسين سلوكياتهم.
 - (١٢) أن يكون هناك اتصال دائم بين المدرسة والمنزل من حيث التركيز على مدي تحسن الطفل في ممارسة اللغة.

١٣) الاهتمام بحث الاطفال على المشاركة والتفاعل فى المناقشات الجماعية، سواء داخل حجرة الدراسة أو خارجها.

١٤) الاهتمام بإظهار جوانب القوة لدى الاطفال، وتنميتها حتى تزداد ثقتهم بأنفسهم.

١٥) الاهتمام بنشر الوعى للشفة الارنبية بشكل عام من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن خلال نشر الأسباب الملموسة حاليًا والتي قد تؤدي الى المشكلات التى تواجه الاطفال نظرا لأن الشفة الارنبية لها تاثير قوي علي الطفل المصاب بها .

١٦) قيام المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم لأسر اطفال الشفة الارنبية حتى يتمكنوا من رعايتهم، وتوفير الحقوق الأساسية لهم.

١٧) الاهتمام بتقديم الدعم الاجتماعي والمادى بكافة أشكاله لاطفال هذه الفئة.

١٨) عقد دورات تدريبية للآباء و للمعلمين لتوضيح خصائص هذه الفئة وأهمية تأثيرها فى نموهم المتكامل.

١٩) متابعة المؤسسات الحكومية كالمستشفيات و مراكز الرعاية الصحية بهؤلاء الحالات بعد ولادتهم و قبل العمليه و اثناء العمليه و بعد العمليه الجراحية الخاصة بالشفة الارنبية.

٢٠) الزام الآباء و المسؤولين بالاهتمام بهؤلاء الفية منذ ولادتها صحيا و نفسيا و اجتماعيا.

دراسات مقترحة:

استنادًا إلى الإطار النظرى والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة عدد من الموضوعات البحثية التى تحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات للوقوف على نتائجها:

- ١) علاقة فرط الحركة باضطرابات الكلام لاطفال الشفة الارنبية.
- ٢) علاقة فرط الحركة و اضطراب السلوك عند اطفال الشفة الارنبية.
- ٣) علاقة الشفة الارنبية و تشوة اللغة لدي اطفال الشفة الارنبية .

المراجع :

ابو شوارب, ختام .(٢٠١٣). *فاعلية برنامج ارشادي للتخفيف من اعراض نقص الانتباه و النشاط الزائد لدي اطفال الروضة* (رسالة ماجستير ,الجامعة الاسلامية غزة). الجامعة الاسلامية غزة.

www.iugaza.edu.ps

ابو عاصي , عادل حسن علي .(٢٠١١). *الاضطرابات النطقية عند الطفل (دراسة صوتية وصفية في ضوء علم الاصوات النطقي* (رسالة ماجستير , الجامعة الاسلامية غزة). الجامعة الاسلامية غزة. اطفال

الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة. www.gulfkids.com

احمد, السيد علي , و بدر, فائقة محمد . (٢٠٠٤) . *اضطراب ضعف الانتباه و النشاط الزائد لدي الاطفال : اسبابه و تشخيصه و علاجه*, الرياض , الاكاديمية العربية للتربية الخاصة .

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشقة الأرنبية

اسماعيل, عيناث ثابت.(٢٠١٧). *دراسة استكشافية وقائية للاضطراب ما وراء المعرفي لدى الاطفال المصابين بفرط النشاط الحركي مع قصور في الانتباه*(رسالة دكتوراة, كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية). جامعة ابي بكر بلقايد.

البطانية, محمد سعد.(٢٠١٢). *فاعلية برنامج تدريبي للتدخل المبكر في علاج اضطرابات النطق للاطفال ذوي الاعاقة العقلية* (رسالة ماجستير, كلية العلوم التربوية و النفسية). جامعة عمان العربية .

الجبالي, احمد علي.(٢٠١١). *اضطراب ضعف الانتباه و النشاط الزائد لدى الاطفال ذوي صعوبات التعلم و علاقته بالسلوك العدواني*(رسالة ماجستير, كلية العلوم التربوية و النفسية). جامعة عمان العربية.

www.moe.gov.jo

الحمد, خالد بن عبد العزيز . (٢٠١٠) . *مدي معرفة معلمي التربية الخاصة باضطراب نقص الانتباه و النشاط الحركي الزائد* : دراسة استطلاعية ,مجلة الارشاد النفسي , العدد (٢٥) , (٢١٥-٢٦٧) .

الرويتع , عبد الله عبد العزيز . (٢٠٠٢) . *اضطراب قصور الانتباه و النشاط الزائد , مجلة الطفولة و التنمية , العدد (٦) , مجلد (٢) , (٣٩-٥٣) .*

الزراع , نايف بن عابد . (٢٠٠٧). *اضطراب ضعف الانتباه و النشاط الزائد* , دار الفكر , الاردن .
السعيد, حمزة.(١٩٩٩). *العيوب الابدالية عند الاطفال الطبيعيين ما بين (٣-٧)سنوات* - رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة الاردنية, عمان.

الصبي, عبدالله محمد , والحايك, سمر عمر, و الزهراني, سعدي .(٢٠١٩). *شقي الشقة و الحنك* . فهرسة مكتبة الملك الوطنية اثناء النشر, الرياض.

الشخص, عبد العزيز السيد .(١٩٩٧). *اضطرابات النطق والكلام*, مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض .
الظاهر, قحطان احمد .(٢٠١٠). *اضطراب اللغة و الكلام*. دار وائل للنشر و التوزيع .

العتار, زينب.(٢٠٠٨). *انتشار اضطرابات النطق و الكلام و علاقتهما بالعمر و الجنس و المستوي الاجتماعي و الاقتصادي*. رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة دمشق.

الغامدي, نورة بنت عبدالله.(٢٠٢١). *مظاهر اضطرابات النطق و اللغة لدى اطفال فرط الحركة و تشتت الانتباه من وجهة نظر اولياء امورهم في ضوء بعض المتغيرات بمدينة جدة*. المجلة العربية للعلوم و الاعاقة

و الموهبة, ٥(١٧). Doi : 10.21608/jasht.2021.182632

القاضي, خالد.(٢٠١١). *تعديل سلوك الاطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط الزائد : دليل عملي للوالدين و المعلمين* , عالم الكتب .

المهدي , محمد . (٢٠١٠) . *الصحة النفسية للطفل* , مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة .

الميلادي, عبد المنعم . (٢٠٠٤) . *مشاكل نفسية تواجه الطفل* , مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية , مصر .

النوايسة ، اديب عبدالله ، القطاونة ، ايمان طه . (٢٠١٥) . **النمو اللغوي و المعرفي للطفل** . عمان ، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ، دار الاعصار العلمي للنشر و التوزيع .

اوزي ، احمد . (٢٠٠٨) . **الاطفال ذوو النشاط الحركي الزائد - التشخيص و العلاج** ، مجلة التربية ، العدد (٢٥) ، (١١٤-١١٧) .

اليوسفي ، مشيرة عبد الحميد . (٢٠٠٥) **النشاط الزائد لدي الاطفال** ، ط ٢ ، المركز الجامعي الحديث ، مصر اليوسفي ، مشيرة عبد الحميد . (٢٠٠٥) . **النشاط الزائد لدي الاطفال** ، **الاسباب و برامج الخفض** ، ط ٢ ، المكتب الجامعي الحديث للنشر و التوزيع ، الاسكندرية .

اليحمدي ، محفوظة بنت سالم . (٢٠١٤) . **فاعلية برنامج ارشادي في خفض النشاط الزائد لدي طلبة الحلقة الاولى من التعليم الاساسي في سلطنة عمان** (رسالة ماجستير ، كلية العلوم و الاداب جامعة نزوي) . جامعة نزوي . Websit : www.unizwa.edu.om

بطرس ، بطرس حافظ . (٢٠١٠) . **تعديل و بناء سلوك الاطفال** ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ، الاردن بطرس ، بطرس حافظ . (٢٠١٠) . **المشكلات النفسية و علاجها** ، الطبعة الثانية ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان .

بوكرمة ، فاطمة الزهراء ، بوجملين ، حياة . (٢٠١٠) . **تأثير اضطراب تشتت الانتباه و فرط النشاط ADHD علي الدافع و التحصيل الدراسي لدي الاطفال - دراسة ميدانية ل (٥٠) حالة** ، مجلة دراسات في الطفولة ، (١١-٢٥) .

بطرس ، بطرس حافظ . (٢٠٠٨) . **المشكلات النفسية وعلاجها** ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، الأردن . بيبى ، هدى . (٢٠٠٠) . **المرجع في الارشاد التربوي اكايمي** ، بيروت . جريسات ، رائدة عيسي . (٢٠١٠) . **العوامل المؤثرة في انتشار ظاهرة ضعف الانتباه و النشاط الزائد لدي عينة من طلاب المدارس الاردنية** ، **المجلة التربوية** ، العدد (٢٨) ، (٣-٢٧) .

حسين ، طه عبد العظيم . (٢٠١٠) . **الصحة النفسية و مشكلاتها لدي الاطفال** ، دار الجامعة الجديدة ، مصر حسين ، وفاء . (٢٠١٠) . **اضطراب التشوية لدي اطفال الاضطرابات النطقية و علاقته ببعض المتغيرات** . رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة دمشق .

خالد ، ريم فهمي . (٢٠١٢) . **فاعلية برنامج علاج طبيعي في خفض النشاط الزائد لدي الاطفال ذوي الصعوبات التعليمية** (رسالة ماجستير ، كلية العلوم التربوية) . جامعة عمان العربية .

www.moe.gov.jo

خليفة ، وليد السيد . (٢٠٠٨) . **كيف يتعلم المخ ذو النشاط الزائد المصحوب بتشتت الانتباه** ، د ط ، دار الاوائل ، الأردن .

زيتاني ، مازن . (٢٠٠٩) . **دراسة العوامل المؤثرة علي نكس العمل الجراحي بعد عمليات اغلاق شق الحنك** . مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية ، ٢٥ (١) .

علاقة فرط النشاط الحركي ببعض اضطرابات اللغة لدى عينة من أطفال الشفة الأرنبية

- سرية , عصام نور. (٢٠٠٢) *سيكولوجية الطفولة* , مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية .
- سيسالم , كمال. (٢٠٠١) . *اضطراب قصور الانتباه و الحركة المفرطة : خصائصها و اسبابها و اساليب علاجها* , دار الكتاب الجامعي , العين , الامارات.
- سيسالم , كمال سالم . (٢٠٠١) . *اضطراب نقص الانتباه و الحركة المفرطة , خصائصها و اساليب علاجها* , دار الكتاب الجامعي , الامارات العربية , العين .
- سيد,وليد فاروق.(٢٠٢٠). *بناء معايير و مؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات المساندة و البرامج النوعية للأطفال ذوي اضطرابات تخاطب اللغة و الكلام و مدي مطابقة مخرجاتها علي مؤسسات و مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بجمهورية مصر العربية* .مجلة البحث في التربية و علم النفس , ٣٥(٤),٣٥٨. <http://mathj.journals.ekb.eg/>
- شاهين ,احمد اكرم.(٢٠١٠). *اثر برنامج علاجي لمعالجة الاضطرابات الصوتية و النطقية التي يواجهها الاطفال في مرحلة ما قبل المدرسة و مرحلة رياض الاطفال (في محافظة الزرقاء في المملكة الاردنية الهاشمية)*.بتاريخ (٢٠١٣\٢٦-h-٢٠١٤:٢٠) Akram 2/99 <http://sites.google.com/site/drahmed>
- علاونة ,شفيق فلاح. (٢٠٠٤) . *سيكولوجية التطور الانساني من الطفولة الي الرشد* .دار المسيرة ,عمان.
- فاكهاني, نور.(٢٠١٥). *المشكلات الانفعالية الشائعة لدى الاطفال المصابين بشق الشفة و قبة الحنك(رسالة ماجستير,كلية التربية قسم الارشاد النفسي)جامعة دمشق*.
- فراج ,عثمان لبيب. (٢٠٠٢) . *الاعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة - تعريفها - تصنيفها -اعراضها - تشخيصها - اسبابها -التدخل العلاجي* ,المجلس العربي للطفولة و التنمية , القاهرة .
- فيصل محمد خير الزارد و غالب خليل الخلايلي. (٢٠٠٢) . *اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاندفاع بالسلوك لدى الأطفال* , د ط , منشورات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية , الإمارات العربية المتحدة
- مجيد , سوسن شاكور . (٢٠٠٨) . *مشكلات الاطفال النفسية و الاساليب الارشادية لمعالجتها* , دارصفاء للنشر و التوزيع , عمان .
- محمدي, فوزية. (٢٠١١). *فعالية برنامجيين تدريبين في تعديل سلوك اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت الانتباه و تعديل صعوبة الكتابة (رسالة دكتوراة, كلية العلوم الاجتماعية الانسانية)*.جامعة قاصدي مرباح ورقلة. www.gulfids.com
- مصطفي ,اسامة فاروق. (٢٠١١). *مدخل الي الاضطرابات السلوكية و الانفعالية* , ط ١٠, دار المسيرة للنشر و التوزيع , عمان .

ملحم، سامي محمد. (٢٠١٠). *مشكلات طفل الروضة - الأساس النظرية و التشخيصية* ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، عمان .

يوسف ، يوسف جلال ، زكريا ، يحيي . (٢٠٠٠) . *دراسة تشخيصية علاجية لدى اطفال المرحلة الابتدائية* ، *مجلة كلية التربية* ، العدد الرابع و العشرون ، الجزء الرابع ، (313 -- 347).

Barkley, R. A., (1998). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*. New York: Guildford Press.

Barkley, R.A. (1990). *Attention Deficit Hyperactivity Disorder A handbook for diagnosis and treatment*. (2th ed) The Gulford press : New York.

Batson, K. and Simone , A. (2002). "The effect of methylphenidate on neuropsychological functioning in children with attention deficit hyperactivity disorder", *Dissertation Abstract International*, vol . 62(11B) , 5380.

Brenner J. (2007). *The effect of Physiotherapy in a Group on the Motor Function of Children with Developmental Coordination Disorder*. Unpublished Master Research report, (University of the Witwater sand).

Byron, J and Phillip, S. and Wackym , A. (2009). *Ballenger's otorhinolaryngology: head and neck surgery*, 17th, PMPH, USA.

Packman, Jill; Bratton, Sue C. (2003), "A School-Based Group Play/Activity Therapy Intervention with Learning Disabled Preadolescents Exhibiting Behavior Problems", *International Journal of Play Therapy*, [Online], 12(2): 7-29.

Carol R & Lensch . (2000). *Making sense of Attention Deficit Hyperactivity Disorder*. *Bergin and Garvey*. West port , Connecticut. London.

Caldaerlla , Paull & et al (2009): *The impact of gender Chinese elementary school teacher's perceptions of student behavior problems*, *New Horizons in education*, v.57, N.2, p17-31.

-Davison, Gerald C., Neale, John M., Kring, Ann M. (2004). *"Abnormal Psychology "* , John Wiley & Sons, Inc. U.S.A.

Edelman S. (2011). *Non- Rando mised Clinical Trial Of Intensive Versus Weekly Physiotherapy For Children With Minor Motor Difficulties*. Unpublished Master Research report, (University of the Witwatersrand).

Fowler, M . (2002) . *Attention deficit hyperactivity disorder national information center for children and youth disabilities*. from : [http / www/ Idon line _org /idin depth/ add _adhd /niehcy. /](http://www/Idon line _org /idin depth/ add _adhd /niehcy. /)

Fowler, M. (2002). *Attention deficit hyperactivity disorder. National Information Center For Children and Youth with Disabilities*. From, [http// www/ Idon linorg/ id- inde pth/ add- adhd/ add- niehcy. Htmll](http://www/Idon linorg/ id- inde pth/ add- adhd/ add- niehcy. Htmll).

Gapin , J. (2009). *Associations Among Physical Activity, ADHD Symptoms and Executive Function in Children with ADHD*. The University of North Carolina at Greensboro.

Gibson ,d. (2003). *Effects of grammar facilitation on the phonological performance of children with speech and language impairments* .j.speech and hearing research , 37.597-607.

Hanson, m. j. (2002). *Efficacy of speech therapy in children with language disorders : specific language impairment compared with language impairment in co-morbidity with cognitive delay.intern j. pediatric ot orhinolaryngology*,63(2):129-136.-

Mayes, D. S., Calhoun, S.L. & Crowell, E. W. (2000). *Learning disabilities and ADHD: overlapping spectrum disorders*. Journal of learning disabil 33 (5), 417-423.

Harvey, E., Danforth, J., McKee, T., Ulozek , W. & Friedman, J.(2003). *"Parenting of children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): The Role of Parental Symptomology*, "Journal of Attention Disorder, 7, 31-42.

Harpin , V.A. (2013). *The effect of ADHD on the life of an individual, their family, and community from preschool to adult life* , www.archdischild.com.

Morand .K. (2004).*The Effects of Mixed Martial Arts on Behavior of Male Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder* . Doctorate thesis, Hofstra University.

Naderi ,F., Heidarie , A., Bouron, L., and Asgari, P. (2010), "*The Efficacy of Play Therapy on ADHD, Anxiety and Social Maturity in 8 to 12 Years Clinics*". *Journal of Applied Sciences*, 10: 189-195. Aged Clientele Children of Ahwaz Metropolitan Counseling.

Reid, R., Ricco , C.A., Kessler, R.H., Dupaul , G.J., Power, T.J., Anastopoulos , A.D., Rogers, A.D.,& Noll, M.B. (2000). "*Gender and ethnic differences in ADHD assessed by behavior ratings*", *Journal of Emotional & Behavioral Disorders*, Vol. 8, Issue (1): 38 – 49.

Sciberras , E., Mueller, K. L., Efron , D., Bisset , M., Anderson, V., Schilpzand, E. J., ... & Nicholson, J. M. (2014). *Language problems in children with ADHD: A community-based study*. *Pediatrics*, 133,(5) 793-800.

Volker Gassling , Caroline Christoph, Kristina Wahle, Bernd Koos, Jörg Wiltfang, Wolf-Dieter Gerber, Michael Siniatchkin. (2014): *Children with a cleft lip and palate: An exploratory study of the role of the parent–child interaction*, *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Volume 42, Issue 6, September, Pages 953-958*.

Waternberg, N., Waiserberg, N., Zuk, L., Lerman-Sagie, T. (2007). Developmental Coordination Disorder in Children with Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder and Physical Intervention. *Developmental Medicine and Child Neurology*,49(12):920-25.